

BẢN ĐỀ XUẤT DỰ ÁN DỰ THI

VIETNAMESE STUDENT HACKATHON 2026

Tên sản phẩm/Dự án:	EyeCU – Hệ điều hành nhận thức không gian, tự động điều phối hạ tầng và thông dịch chỉ số y tế thời gian thực.
Bảng dự thi:	Bảng B – CHALLENGER.
Lĩnh vực trọng điểm:	Đề tài 4 – Xây dựng giải pháp AI hỗ trợ công tác khám chữa bệnh/ tối ưu vận hành cơ sở y tế/ nâng cao trải nghiệm người bệnh.
Trường đại học:	Đại học Kinh tế Quốc dân
Thành viên nhóm:	Vũ Thái An - 0385622941 - thaiandseb66a.neu@gmail.com Trịnh Khánh Huyền - 0836130201 - khanhhuyena3nsl@gmail.com Đặng Khoa Nghị - 0358448639 - dangkhoanghi@gmail.com Phạm Thảo Nguyên - 0329199233 - nguyengifted14@gmail.com

Tài nguyên dự án	Đường dẫn truy cập
Web demo	Xem trực tuyến web demo
Slide thuyết trình	Xem trực tuyến bản Slide Đề xuất Dự án
Video Demo & Trình bày	Xem Video Thuyết trình sản phẩm

MỤC LỤC

I	ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT	2
1	Tóm tắt giải pháp (Executive Summary)	2
2	Thực trạng và Số liệu nổi đau (Pain-points) tại Việt Nam	2
3	Chứng minh tính hiệu quả từ các mô hình Quốc tế thành công	3
4	Luận điểm cốt lõi: "Vì sao bắt buộc phải ứng dụng AI?"	4
II	THIẾT KẾ TỔNG QUAN HỆ THỐNG & TÍCH HỢP BỘ API VNPT	5
1	Sơ đồ kiến trúc minh họa luồng dữ liệu (Architecture Diagram)	5
2	Bản đồ Mapping chi tiết và Kịch bản điều phối phối hợp API VNPT	7
2.1	Ma trận Bản đồ Mapping API (API Mapping Matrix)	8
2.2	Kịch bản phối hợp chi tiết qua 5 giai đoạn vận hành	8
3	Hành trình trải nghiệm song song (Dual-User Journey)	10
4	Ma trận tổng hợp điểm chạm công nghệ VNPT	11
5	Hình ảnh Wireframe/Mockup giao diện	12
III	TÍNH ĐỔI MỚI VÀ KHÁC BIỆT CỐT LÕI	16
1	Bảng so sánh và định lượng tính vượt trội của giải pháp	16
2	Điểm đổi mới mang tính bản chất giải pháp (Tính sáng tạo)	16
IV	PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI & TÍNH KHẢ THI KỸ THUẬT	17
1	Nguồn dữ liệu giả lập	17
2	Kỹ thuật Build/Deploy khả thi và Cơ chế dự phòng sự cố (Fallback)	17
2.1	Giải pháp đóng gói Docker Container và Kiến trúc tích hợp mở	17
2.1.1	Cam kết chuẩn triển khai Đơn-lệnh (One-Command Deployment):	18
2.1.2	Kiến trúc tích hợp Plug-and-Play:	18
2.2	Cơ chế dự phòng sự cố thực địa tại Biên (Local Edge Fallback Mechanism)	18
2.2.1	Chế độ vận hành Local Edge ngoại tuyến (Offline Mode):	18
2.2.2	Kích hoạt hạ tầng phần cứng vật lý khẩn cấp:	18
3	Ước tính chi phí hạ tầng và Vận hành tối ưu	19
4	An toàn thông tin và Bảo mật quyền riêng tư (Privacy by Design)	20
5	Lộ trình phát triển sản phẩm (Product Roadmap)	20
V	TÁC ĐỘNG DỰ KIẾN VÀ MÔ HÌNH DOANH THU	21
1	Định lượng quy mô thị trường mục tiêu (TAM - SAM - SOM) tại Việt Nam	21
1.1	Thị trường tiềm năng tối đa (TAM):	21
1.2	Thị trường mục tiêu có thể tiếp cận (SAM):	21
1.3	Thị trường có thể chiếm lĩnh trong ngắn hạn (SOM):	21
2	Chiến lược tiếp cận thị trường bứt phá (Go-to-market Strategy)	21
3	Mô hình doanh thu và Chiến lược định giá (Revenue Model)	22
4	Định lượng chỉ số hiệu quả đầu tư (ROI) và Tác động vận hành	23
VI	PHỤ LỤC	23
1	THUẬT TOÁN ĐỊNH LƯỢNG CHỈ SỐ RỦI RO NHẬN THỨC	23
1.1	Giải nghĩa chi tiết các biến số và hàm số thành phần	23
1.2	Cơ chế tối ưu trọng số và kiểm soát sai số lâm sàng	24
2	Sản phẩm dự án	24

I ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

1 Tóm tắt giải pháp (Executive Summary)

Bước sang năm 2026, trước tốc độ già hóa dân số nhanh chóng, hệ thống y tế công lập – đặc biệt là các bệnh viện đa khoa tuyến đầu – đang phải đối mặt với áp lực quá tải cục bộ, "điểm mù" giám sát nội trú ban đêm và sự nghẽn lệnh trong điều phối hạ tầng khẩn cấp.

Để giải quyết triệt để bài toán này, **EyeCU** ra đời như một hệ điều hành nhận thức không gian toàn diện (Ambient Intelligence). Bằng việc tích hợp sâu hệ sinh thái API của VNPT (SmartVision, SmartVoice, SmartReader, eKYC), giải pháp thiết lập một trục dữ liệu đa phương thức khép kín, tối ưu hóa trải nghiệm không chạm (Zero-Friction). Tại các "chảo lửa" như Khoa Cấp cứu hay Tim mạch, hệ thống tự động chuẩn bị hạ tầng trước khi xe cứu thương tiếp cận, nhận diện chính xác sự cố ngã/kêu cứu qua thị giác và thính giác máy tính để bảo vệ "thời gian vàng", đồng thời giải phóng đôi tay bác sĩ bằng cơ chế ghi bệnh án qua giọng nói. Ở luồng ngoại trú, ứng dụng LLM thông dịch chỉ số y tế giúp giải tỏa nghẽn cổ chai thông tin cho người bệnh.

EyeCU chuyển dịch mô hình vận hành từ "bị động hậu kiểm" sang "chủ động dự báo", mang lại giá trị nhân văn sâu sắc và thiết lập chuẩn mực số hóa đột phá, giải phóng sức tải cho hệ thống y tế hiện đại.

2 Thực trạng và Số liệu nổi đau (Pain-points) tại Việt Nam

Hiện nay, Việt Nam đang đối mặt với tốc độ già hóa dân số thuộc nhóm nhanh nhất thế giới, điều này tạo ra một áp lực đè nén lên hệ thống hạ tầng y tế lão khoa của đất nước (1). Theo báo cáo từ Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), trong khi các quốc gia phát triển phải mất nhiều thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ để dịch chuyển từ xã hội "già hóa" sang xã hội "già", Việt Nam được dự báo sẽ rút ngắn tiến trình này chỉ trong vòng 20 năm (2). Số liệu công bố mới nhất từ Tổng cục Thống kê và Bộ Y tế xác ghi quy mô dân số nước ta đã vượt mốc 101 triệu người, trong đó số lượng người từ 60 tuổi trở lên đạt 14,2 triệu người, chiếm tỷ lệ 14,05% tổng dân số (3). Số liệu này vượt quá dữ liệu đã được dự báo trước đó và vẫn đang tiếp tục tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR). Nhóm dân số này mang đặc trưng lâm sàng là mô hình bệnh tật kép khi trung bình một người cao tuổi Việt Nam mắc từ 3 đến 5 bệnh nền mãn tính, gây ra một cú sốc cầu mạnh mẽ lên hệ thống y tế vốn chưa kịp chuyển đổi cấu trúc để thích ứng.

Bên cạnh đó, điểm nghẽn còn nằm ở điểm mù giám sát ban đêm tại các phòng nội trú, hệ quả trực tiếp từ cuộc khủng hoảng thiếu hụt điều dưỡng nghiêm trọng. Số liệu từ Hội Điều dưỡng Việt Nam và Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) chỉ ra rằng tỷ lệ điều dưỡng/bác sĩ trung bình tại Việt Nam hiện chỉ đạt 1,8 (4), con số này thấp hơn rất nhiều so với khuyến cáo tối thiểu từ 3,0 đến 4,0 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm đảm bảo an toàn lâm sàng. Sự thiếu hụt này đẩy các ca trực đêm tại khoa Lão khoa rơi vào mức báo động khi một điều dưỡng phải chịu trách nhiệm giám sát từ 25 đến 30 bệnh nhân, thậm chí lên tới 40 - 50 người vào đợt cao điểm. Trong khi đó, ban đêm lại là khung giờ nguy hiểm với 80% ca tai nạn trượt ngã hoặc biến chứng đột quỵ của người cao tuổi diễn ra hoàn toàn im lặng ngay tại phòng bệnh. Với tần suất tuần tra thủ công 2 tiếng một lần của điều dưỡng trực ca, các bệnh viện dễ dàng gặp phải "điểm mù giám sát" trong 115 phút còn lại. Nếu sự cố tai nạn xảy ra ngay sau khi điều dưỡng rời phòng, người bệnh phải đối mặt với nguy cơ tử vong hoặc chịu đựng đau đớn cô độc trước khi ca tuần tra tiếp theo bắt đầu.

Hơn nữa, quy trình điều phối cấp cứu truyền thống tại Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc nặng nề vào các thao tác thủ công rời rạc, gây lãng phí nghiêm trọng "thời gian vàng" của người bệnh. Khi tiếp nhận một ca bệnh nguy kịch như đột quỵ hay tim mạch, nhân viên y tế phải tiêu tốn trung bình từ 5 đến 7 phút hành chính bị động chỉ để thực hiện các bước thủ tục, gọi điện thoại tìm giường trống tại khoa ICU, kiểm tra trạng thái sẵn sàng của máy thở bằng sổ sách và điều động kíp trực chuyên khoa bằng bộ đàm. Dưới góc nhìn y khoa, sự chậm trễ này trực tiếp đánh đổi bằng chính sinh mạng con người bởi điều quan trọng nhất trong cấp cứu đột quỵ não là thời gian (5). Theo Hội Đột quỵ Thế giới (WSO), cứ mỗi 1 phút mạch máu não bị tắc nghẽn và không được tái

thông, khoảng 1,9 triệu tế bào thần kinh (neurons) sẽ chết vĩnh viễn. Việc lãng phí vài phút hành chính do hệ thống điều phối thủ công đồng nghĩa với việc phá hủy từ 10 đến hơn 13 triệu tế bào não, làm tăng tỷ lệ tử vong lên gấp 1,5 lần, làm bỏ lỡ cơ hội can thiệp bằng thuốc tiêu sợi huyết trong khung giờ vàng và để lại di chứng tàn phế vĩnh viễn cho bệnh nhân (6).

Điểm nghẽn cuối cùng xuất phát từ tình trạng quá tải hành chính lâm sàng và khủng hoảng thông tin sau khám. Nghiên cứu thời gian và chuyển động chỉ ra rằng nhân viên y tế, đặc biệt là điều dưỡng khoa lão, đang bị đánh mất từ 40% đến 60% tổng thời gian ca trực chỉ để thực hiện các công việc phi lâm sàng như nhập liệu thủ công trên hệ thống HIS/EMR chưa tối ưu, chép tay hồ sơ bệnh án giấy và điền biểu mẫu bảo hiểm y tế nhằm tránh bị xuất toán. Ở chặng sau khám, hầu hết bệnh nhân rơi vào trạng thái hoang mang, hoảng loạn vì không thể tự hiểu các chỉ số hóa sinh viết tắt chuyên môn sâu như HbA1c, Creatinine, AST, ALT trên phiếu kết quả. Hệ quả là một lượng lớn bệnh nhân tự ý quay lại xếp hàng hoặc chen ngang để hỏi lại bác sĩ những câu hỏi cơ bản, vô tình tạo ra một vòng lặp ùn tắc dây chuyền tại khu vực khám ngoại trú, kéo dài thời gian chờ đợi trung bình lên đến 2 - 3 tiếng trong khi thời gian khám thực tế của bác sĩ chỉ chưa đầy 5 phút.

3 Chứng minh tính hiệu quả từ các mô hình Quốc tế thành công

Mô hình Trí tuệ môi trường (Ambient Intelligence) ứng dụng AI nhận thức không gian không chỉ là lí thuyết mà đã được chứng minh hiệu quả vượt trội, mang lại những cuộc cách mạng thực sự tại các hệ thống y tế phát triển trên thế giới. Điển hình là giải pháp SafelyYou, một công nghệ khởi nguồn từ Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo của Đại học UC Berkeley, Hoa Kỳ. Hệ thống này vận hành dựa trên sự kết hợp giữa thiết bị thị giác máy tính tại biên mạng tên SafelyYou Guardian kết nối với hệ thống camera hồng ngoại gắn ở góc trần phòng ngủ của cư dân. Điểm đặc biệt của SafelyYou là luồng video thời gian thực liên tục được xử lý cục bộ thông qua các mạng thần kinh tích chập (CNN) và thuật toán ước lượng tư thế người (human pose estimation) để phân tích 33 điểm mốc (landmarks) trên cơ thể người nhằm xác định các chuyển động bất thường. Nhằm bảo vệ quyền riêng tư, hệ thống áp dụng cơ chế bộ đệm vòng cục bộ để tự động xóa vĩnh viễn video trong vòng 60 giây. Chỉ khi phát hiện một cú ngã với độ chính xác ban đầu trên 99%, hệ thống mới khóa đoạn video ghi nhận sự kiện bao gồm vài phút trước và sau cú ngã để truyền tải mã hóa lên cổng đám mây, phát cảnh báo đến điện thoại của điều dưỡng trực ca trong vòng vài giây. Cơ chế này cho phép nhân viên y tế truy cập trực quan tức thời để thẩm định, phân tích động học cú ngã nhằm thiết lập các can thiệp phòng ngừa cá nhân hóa.

Việc triển khai mô hình SafelyYou mang lại những kết quả lâm sàng và hiệu quả kinh tế định lượng vô cùng ấn tượng. Được chứng minh qua các nghiên cứu khoa học có bình duyệt, giải pháp này giúp giảm trung bình 40% tổng số ca ngã và giảm đến 80% số ca chuyển viện cấp cứu không cần thiết (7). Thời gian nằm sàn trung vị của người cao tuổi sau khi ngã giảm xuống kỷ lục, chỉ còn 1 phút 21 giây so với trung bình ngành là 40 phút, đồng thời giảm 53% số lượng cư dân bị ngã ngay từ tháng thứ hai sử dụng (8). Tỷ lệ ngã gây chấn thương nghiêm trọng phải chuyển viện cấp cứu được kéo giảm xuống chỉ còn 2,9% - 3% tổng số ca ngã, so với mức trung bình ngành rất cao từ 20% đến 23,6%. Về mặt tài chính, việc cắt giảm các ca chuyển viện không cần thiết giúp các gia đình tiết kiệm khoản chi phí tự chi trả tối thiểu 2.907 USD cho mỗi lần điều động xe cấp cứu. Đồng thời, hệ thống bảo vệ dòng doanh thu cho cơ sở nhờ duy trì tỷ lệ lấp đầy giường, giúp các nhà vận hành tăng doanh thu hoạt động thuần (NOI) trung bình 20% hàng năm, tương đương mức tăng lên tới 6.000 USD/cư dân/năm hoặc 87.500 USD/cơ sở/năm nhờ tối ưu hóa quản lý rủi ro.

Song song với thị giác máy tính, phân hệ trợ lý giọng nói rảnh tay (Ambient Voice AI) cũng ghi nhận thành tựu mang tính cách mạng thông qua nền tảng Artisight tại các tập đoàn y tế lớn như UChicago Medicine và The Guthrie Clinic. Artisight thiết lập một kiến trúc toàn diện cho bệnh viện thông minh bằng cách sử dụng thiết bị tích hợp đa cảm biến All-in-One gồm camera AI, mảng micro định hình chùm tia (beamforming), loa đàm thoại hai chiều và công nghệ định vị thời gian thực kết nối thẳng với hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử (EMR). Toàn bộ hạ tầng hoạt động trên

nền tảng điện toán biên (Edge Compute) tăng tốc bởi GPU NVIDIA Jetson để đảm bảo độ trễ dưới mức giây và tuân thủ bảo mật HIPAA. Quy trình trích xuất dữ liệu y khoa từ giọng nói rảnh tay được thực hiện khép kín qua 4 bước: thu âm khi nhận khẩu lệnh kích hoạt "OK Artisight", phân tách người nói bằng công nghệ tối ưu hóa qua thư viện NVIDIA Riva, chuyển văn bản qua mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) y tế để trích xuất thực thể lâm sàng (triệu chứng, tên thuốc, liều lượng), và cuối cùng là tự động điền các dữ liệu cấu trúc này vào bệnh án điện tử EMR qua API thời gian thực.

Nền tảng Ambient Voice AI này đã tối ưu hóa hiệu năng vận hành lâm sàng và giải phóng một lượng giờ công khổng lồ cho đội ngũ y tế. Cụ thể, hệ thống giúp tiết kiệm trung bình 5,5 giờ công/ngày/khoa phòng thông qua sự trợ giúp của điều dưỡng ảo và tự động hóa tài liệu (9). Mỗi điều dưỡng giảm được hơn 30 phút/ca trực đối với tác vụ nhập liệu thủ công vào hệ thống EMR. Ngoài ra, quy trình tiếp nhận hoặc cho xuất viện bệnh nhân cũng được rút ngắn hơn 25 phút, quy trình chuẩn bị tiền phẫu tiết kiệm tới 45 phút/bệnh nhân nhờ tự động hóa bảng kiểm an toàn. Hơn 50% bệnh nhân được cho xuất viện nhanh trong vòng 75 phút so với trung bình quốc gia là 120-150 phút. Hiệu quả này giúp giảm tải áp lực, kéo giảm tỷ lệ nghỉ việc của điều dưỡng từ 25% xuống còn 13%, thậm chí có đơn vị về mức 0% (10). Đồng thời, hệ thống cắt giảm hơn 90% số giờ cần nhân viên trực giám sát trực tiếp tại giường, giảm tới 78% số ca ngã nội trú và mang lại mức tiết kiệm tài chính trực tiếp lên đến 7 triệu USD chi phí nhân sự tại hệ thống bệnh viện The Guthrie Clinic (11). Việc loại bỏ các rào cản hành chính này là cơ chế trực tiếp giúp điều dưỡng tăng tối đa quỹ thời gian túc trực để chăm sóc trực tiếp bên giường bệnh, cải thiện rõ rệt chỉ số hài lòng của người bệnh.

4 Luận điểm cốt lõi: "Vì sao bắt buộc phải ứng dụng AI?"

Để giải quyết triệt để bốn điểm nghẽn nghiêm trọng nêu trên, việc duy trì hoặc nâng cấp các hệ thống quản lý bệnh viện truyền thống (HIS) thông thường đã không còn khả thi. Về mặt bản chất kỹ thuật, các phần mềm HIS hiện nay hoạt động thuần túy dựa trên cơ chế nhập liệu tĩnh từ con người và thực hiện hậu kiểm, nghĩa là chỉ ghi nhận và phân tích sau khi sự việc dữ liệu đã được số hóa và xảy ra xong. Hệ thống truyền thống hoàn toàn bị giới hạn bởi các kiến trúc mã nguồn cứng (rule-based), chỉ có thể xử lý các dạng dữ liệu đã được cấu trúc hóa rõ ràng trong các bảng cơ sở dữ liệu. Trong khi đó, toàn bộ luồng dữ liệu thực địa tại các khoa phòng và phòng cấp cứu lại tồn tại dưới dạng dữ liệu phi cấu trúc với độ biến động cực kỳ cao theo thời gian thực, bao gồm luồng livestream liên tục từ camera an ninh, tín hiệu âm thanh nhiễu chứa tiếng kêu cứu tiếng Việt, hay ảnh chụp các phiếu xét nghiệm lộn xộn từ tuyến dưới. Đây là những bài toán mã nguồn truyền thống không thể tự bóc tách thực thể hay đưa ra các phản ứng tự động nếu không có sự can thiệp thủ công của con người. Do đó, việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đa phương thức (Multimodal AI) là một yêu cầu bắt buộc mang tính sống còn để hệ thống tự nhận thức không gian, tự động bóc tách thực thể và đưa ra các phân tích thời gian thực ngay tại biên (Real-time Edge Analytics).

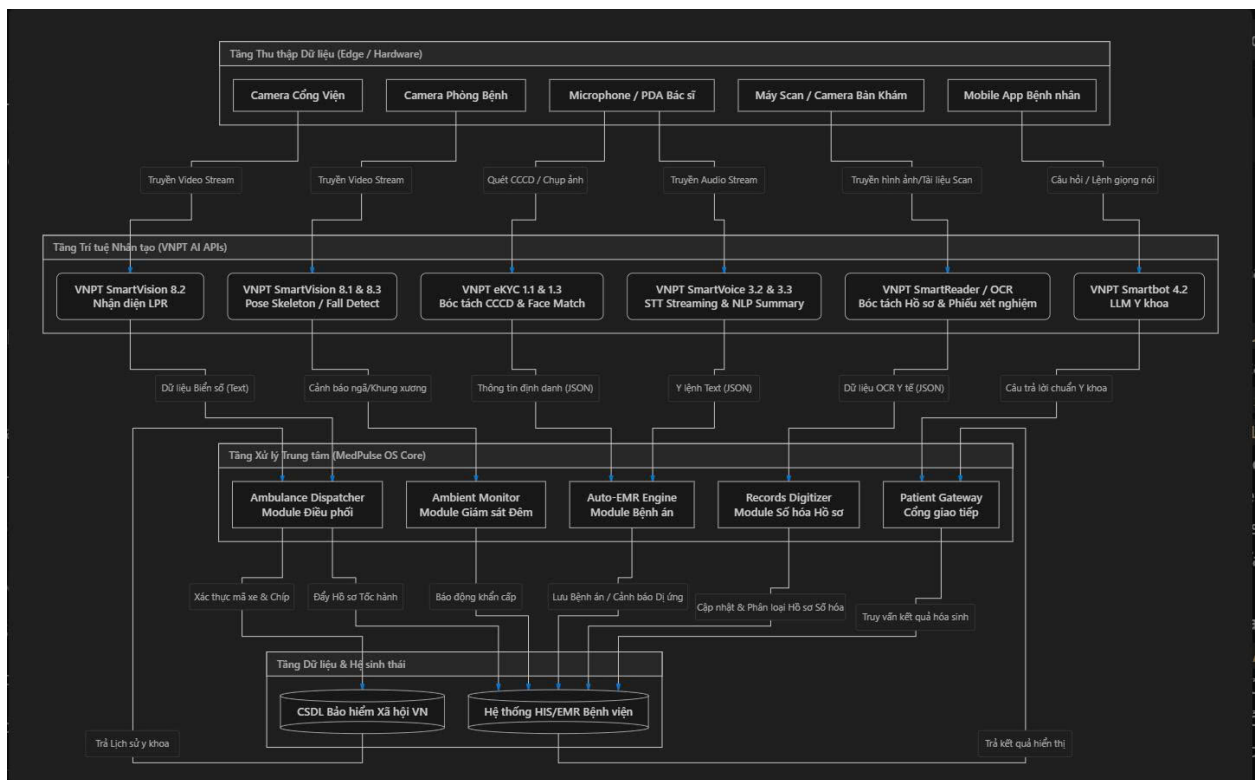
Sự bắt buộc này còn xuất phát từ yêu cầu dịch chuyển mô hình vận hành y tế từ bị động phản ứng sang chủ động dự báo và phòng ngừa. Con người và hệ thống cũ luôn vận hành ở thế bị động: đợi xe cấp cứu đến mới làm thủ tục chuẩn bị, đợi điều dưỡng đi tuần ca mới phát hiện bệnh nhân ngã, hay đợi bác sĩ giải thích từng chỉ số xét nghiệm thô cho người bệnh. Sự chậm trễ này trực tiếp làm tiêu tốn "thời gian vàng" lâm sàng và bào mòn quỹ thời gian chuyên môn của nhân viên y tế cho các thủ tục giấy tờ hành chính. Chỉ có AI mới có khả năng chạy ngầm 24/7/365 để kết nối các chiều dữ liệu phi cấu trúc độc lập, biến các tương tác vật lý tự nhiên trong không gian thành các y lệnh số và hành động IoT điều phối hạ tầng tự động.

Đặc biệt, tại thị trường Việt Nam, việc ứng dụng một hệ thống AI được tối ưu hóa bản địa là rào cản kỹ thuật chí mạng mà các mô hình ngoại bang hàng đầu thế giới (như OpenAI Whisper) chưa thể giải quyết trọn vẹn. Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm tiết có tính thanh điệu phức tạp với 6 thanh điệu khác nhau, nơi một sự thay đổi rất nhỏ về tần số cơ bản của giọng nói sẽ làm thay đổi hoàn toàn nghĩa lâm sàng của từ khóa y tế. Thách thức này nhân lên gấp bội khi đối mặt với sự bất cân bằng dữ liệu và sự khác biệt lớn trong khẩu âm, phương ngữ của ba miền Bắc - Trung

- Nam, cùng với tần suất đan xen ngôn ngữ Anh - Việt (Code-switching) và các ký hiệu viết tắt đặc thù ngành y tại Việt Nam. Các mô hình toàn cầu khi cài đặt zero-shot thường gặp hiện tượng suy giảm hiệu năng nghiêm trọng, đẩy tỷ lệ lỗi từ vựng (WER) và tỷ lệ lỗi trên các vùng thông tin nhạy cảm y tế (PIER) lên mức không an toàn cho lâm sàng. Do đó, việc xây dựng một hệ điều hành thông minh như EyeCU, được tích hợp và tinh chỉnh chuyên sâu trên nền tảng hệ sinh thái API lõi bản địa hóa của VNPT, là lời giải duy nhất để đảm bảo tính chính xác, an toàn và khả năng ứng dụng thực tế cao trong môi trường bệnh viện Việt Nam.

II THIẾT KẾ TỔNG QUAN HỆ THỐNG & TÍCH HỢP BỘ API VNPT

1 Sơ đồ kiến trúc minh họa luồng dữ liệu (Architecture Diagram)



Hình 1: Sơ đồ Kiến trúc hệ thống và Luồng dữ liệu (Data Flow) của EyeCU

2.1.1. Mô tả chi tiết chức năng phân tầng của hệ thống

1. TẦNG THU THẬP DỮ LIỆU (EDGE / HARDWARE LAYER)

Đây là lớp tiếp xúc trực tiếp với môi trường thực tế của bệnh viện, chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu đầu vào dưới nhiều hình thức khác nhau.

- **Camera Cổng Viện:** Thu nhận luồng video thời gian thực phục vụ nhận diện phương tiện ưu tiên và hỗ trợ điều phối cấp cứu.
- **Camera Phòng Bệnh:** Giám sát không gian nội trú, cung cấp dữ liệu hình ảnh phục vụ phát hiện tư thế ngã và các tình huống bất thường trong phòng bệnh.
- **Microphone / PDA Bác sĩ:** Thu nhận luồng âm thanh trong quá trình thăm khám, hội chẩn và theo dõi nội trú, phục vụ nhận dạng giọng nói và phát hiện tín hiệu khẩn cấp.

- **Máy Scan / Camera Bàn Khám:** Tiếp nhận ảnh chụp hồ sơ bệnh án, phiếu xét nghiệm, CCCD và các giấy tờ liên quan.
- **Ứng dụng Di động Người bệnh:** Là điểm tương tác giữa người bệnh với hệ thống, tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản hoặc giọng nói để truy vấn thông tin sức khỏe.

2. TẦNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (VNPT AI APIs LAYER)

Đây là lớp xử lý trung gian, chuyển đổi dữ liệu phi cấu trúc thành dữ liệu có cấu trúc để phục vụ các nghiệp vụ y tế.

- **VNPT SmartVision (API 8.2):** Xử lý luồng video từ camera cổng viện nhằm nhận diện biển số xe và trích xuất thông tin phương tiện dưới dạng dữ liệu cấu trúc.
- **VNPT SmartVision (API 8.1 & 8.3):** Phân tích hình ảnh phòng bệnh để phát hiện tư thế ngã, xây dựng dữ liệu khung xương (Skeleton Data) và tạo cảnh báo sự cố nội trú.
- **VNPT SmartVoice (API 3.2 & 3.3):** Chuyển đổi giọng nói thành văn bản theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ phân tích và tóm tắt nội dung phục vụ bệnh án điện tử.
- **VNPT eKYC (API 1.1 & 1.3):** Thực hiện trích xuất thông tin định danh và đối sánh khuôn mặt nhằm hỗ trợ xác thực danh tính người bệnh.
- **VNPT SmartReader OCR:** Nhận dạng ký tự quang học và bóc tách dữ liệu từ hồ sơ y tế, phiếu xét nghiệm hoặc giấy tờ hành chính.
- **VNPT Smartbot nâng cao (API 4.2):** Cấu phần trí tuệ nhân tạo nâng cao sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để thông dịch tri thức y khoa.

3. TẦNG XỬ LÝ TRUNG TÂM (EyeCU CORE)

Đây là bộ não điều phối của toàn hệ thống, tiếp nhận dữ liệu đã xử lý từ các API AI và thực hiện các nghiệp vụ chuyên biệt.

- **Ambulance Dispatcher (Module Điều phối)**
 - Tiếp nhận dữ liệu nhận diện phương tiện từ SmartVision 8.2.
 - Hỗ trợ xác thực xe cấp cứu và điều phối quy trình tiếp nhận khẩn cấp.
- **Ambient Monitor (Module Giám sát đêm)**
 - Tiếp nhận cảnh báo ngã và dữ liệu khung xương từ SmartVision.
 - Giám sát không gian nội trú và phát sinh cảnh báo khi phát hiện sự cố.
- **Auto-EMR Engine (Module Bệnh án)**
 - Tiếp nhận dữ liệu văn bản từ SmartVoice.
 - Tự động lưu trữ và hỗ trợ điền thông tin vào bệnh án điện tử.
- **Records Digitizer (Module Số hóa hồ sơ)**
 - Tiếp nhận dữ liệu OCR từ SmartReader và dữ liệu định danh từ eKYC.
 - Chuẩn hóa và cập nhật hồ sơ bệnh nhân dưới dạng dữ liệu số.
- **Patient Gateway (Cổng giao tiếp)**
 - Kết nối với Smartbot nâng cao (API 4.2).
 - Hỗ trợ người bệnh tra cứu thông tin sức khỏe, kết quả xét nghiệm và nhận giải thích bằng ngôn ngữ dễ hiểu.

4. TẦNG DỮ LIỆU & HỆ SINH THÁI

Sau khi được xử lý, dữ liệu được đồng bộ tới các hệ thống nghiệp vụ liên quan.

- **Hệ thống HIS/EMR Bệnh viện**

- Lưu trữ hồ sơ khám chữa bệnh, bệnh án điện tử và dữ liệu vận hành.
- **Cơ sở dữ liệu Bảo hiểm Xã hội Việt Nam**
 - Hỗ trợ đối chiếu và khai thác thông tin phục vụ quy trình khám chữa bệnh.

2.1.2. Mô tả các luồng giao thức và định dạng dữ liệu truyền tải

- **Luồng dữ liệu từ Tầng Thu thập dữ liệu đến Tầng AI**

- Luồng video từ Camera Cổng viện và Camera Phòng bệnh được truyền tới các dịch vụ SmartVision để thực hiện phân tích hình ảnh.
- Luồng âm thanh từ Microphone/PDA Bác sĩ được gửi tới SmartVoice để thực hiện nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ.
- Hình ảnh hồ sơ, CCCD và phiếu xét nghiệm được gửi tới eKYC và SmartReader thông qua các kết nối bảo mật để thực hiện trích xuất dữ liệu.
- Các câu hỏi hoặc lệnh giọng nói từ ứng dụng người bệnh được chuyển tới Smartbot nâng cao (API 4.2) để xử lý hội thoại.

- **Luồng dữ liệu từ Tầng AI đến EyeCU Core**

- **Dữ liệu biển số xe (Text):** Được trả về từ SmartVision 8.2 và chuyển tới Ambulance Dispatcher Module.
- **Dữ liệu cảnh báo ngã và khung xương (Skeleton Data):** Được trả về từ SmartVision 8.1 & 8.3 và chuyển tới Ambient Monitor Module.
- **Dữ liệu định danh (JSON):** Được trả về từ eKYC để phục vụ xác thực và quản lý hồ sơ.
- **Y lệnh dạng văn bản (Text/JSON):** Được trả về từ SmartVoice để phục vụ Auto-EMR Engine.
- **Dữ liệu OCR y tế (JSON):** Được trả về từ SmartReader để phục vụ Records Digitizer Module.
- **Câu trả lời chuẩn hóa y khoa (Text Response):** Được trả về từ Smartbot nâng cao (API 4.2) để phục vụ Patient Gateway.

- **Luồng dữ liệu đầu ra**

- EyeCU Core đồng bộ hồ sơ và dữ liệu vận hành tới hệ thống HIS/EMR.
- Các cảnh báo nội trú được hiển thị trên Dashboard Command Center dành cho điều dưỡng và nhân viên vận hành.
- Kết quả xét nghiệm, tư vấn sức khỏe và phản hồi từ trợ lý AI được hiển thị trên ứng dụng di động dành cho người bệnh.

2 Bản đồ Mapping chi tiết và Kịch bản điều phối phối hợp API VNPT

Hệ điều hành EyeCU vận hành dựa trên cơ chế phối hợp đa phương thức giữa các nguồn dữ liệu hình ảnh, âm thanh và hồ sơ y tế. Các API thuộc hệ sinh thái VNPT AI đóng vai trò chuyển đổi dữ liệu phi cấu trúc thành dữ liệu có cấu trúc, tạo nền tảng cho các mô-đun nghiệp vụ của EyeCU Core Engine.

2.1 Ma trận Bản đồ Mapping API (API Mapping Matrix)

Hệ điều hành EyeCU vận hành dựa trên cơ chế phối hợp đa phương thức giữa các nguồn dữ liệu hình ảnh, âm thanh và hồ sơ y tế. Các API thuộc hệ sinh thái VNPT AI đóng vai trò chuyển đổi dữ liệu phi cấu trúc thành dữ liệu có cấu trúc, tạo nền tảng cho các mô-đun nghiệp vụ của EyeCU Core Engine.

Giai đoạn	Nguồn dữ liệu vào	Cấu phần API VNPT xử lý	Định dạng đầu ra	Khối chức năng chịu trách nhiệm
G1: Điều phối khẩn cấp	Luồng video cổng viện	VNPT SmartVision (API 8.2)	Text (Biển số xe)	Ambulance Dispatcher Module
G2: Số hóa danh tính	Ảnh scan hồ sơ, CCCD, phiếu xét nghiệm	VNPT eKYC (API 1.1, 1.3) và VNPT SmartReader OCR	JSON	Records Digitizer Module
G3: Bệnh án rảnh tay	Tín hiệu âm thanh phòng khám	VNPT SmartVoice (API 3.2, 3.3)	Text / Clinical Summary	Auto-EMR Engine
G4: Giám sát nội trú	Luồng video và âm thanh phòng bệnh	VNPT SmartVision (API 8.1, 8.3) và VNPT SmartVoice (API 3.2)	Skeleton Data / Event Alert / Text	Ambient Monitor Module
G5: Trợ lý thông dịch	Dữ liệu hồ sơ và kết quả xét nghiệm	VNPT Smartbot nâng cao (API 4.2)	Text Response	Patient Gateway

Bảng 1: Ma trận Mapping API của hệ thống EyeCU

2.2 Kịch bản phối hợp chi tiết qua 5 giai đoạn vận hành

Giai đoạn 1: Tiếp nhận và Điều phối khẩn cấp

Luồng video từ Camera Cổng viện được gửi tới VNPT SmartVision (API 8.2) để nhận diện biển số phương tiện ưu tiên. Thông tin nhận diện được chuyển về Ambulance Dispatcher Module của EyeCU Core Engine nhằm hỗ trợ quy trình tiếp nhận cấp cứu và gửi cảnh báo sớm tới đội ngũ y tế. Nhờ đó, bệnh viện có thể chủ động chuẩn bị nguồn lực trước khi bệnh nhân được đưa tới khu vực cấp cứu.

Giai đoạn 2: Số hóa danh tính và hồ sơ y tế

Khi tiếp nhận người bệnh, nhân viên y tế thực hiện quét CCCD, hồ sơ giấy và phiếu xét nghiệm.

- VNPT eKYC thực hiện trích xuất thông tin định danh và đối sánh khuôn mặt nhằm hỗ trợ xác thực danh tính người bệnh.
- VNPT SmartReader OCR tiến hành nhận dạng và bóc tách dữ liệu từ hồ sơ y tế để chuyển đổi thành dữ liệu số có cấu trúc.
- Kết quả xử lý được chuyển tới Records Digitizer Module để chuẩn hóa và cập nhật hồ sơ bệnh nhân trong hệ thống.

Giai đoạn 3: Trợ lý bệnh án rảnh tay

Trong quá trình khám bệnh, bác sĩ có thể đọc trực tiếp các nhận định lâm sàng và y lệnh bằng giọng nói. VNPT SmartVoice (API 3.2, 3.3) tiếp nhận luồng âm thanh, chuyển đổi thành văn bản và hỗ trợ tóm tắt nội dung chuyên môn. Auto-EMR Engine sau đó tự động điền các trường dữ liệu tương ứng vào biểu mẫu bệnh án điện tử, góp phần giảm thời gian nhập liệu thủ công và nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên y tế.

Giai đoạn 4: Giám sát không gian nội trú

Tại khu vực nội trú, Camera Phòng bệnh liên tục gửi luồng hình ảnh tới VNPT SmartVision

(API 8.1, 8.3) để phát hiện tư thế ngã và xây dựng dữ liệu khung xương phục vụ giám sát. Song song với đó, SmartVoice tiếp nhận luồng âm thanh từ môi trường phòng bệnh để phát hiện các tín hiệu bất thường hoặc yêu cầu hỗ trợ. Ambient Monitor Module tổng hợp các nguồn dữ liệu hình ảnh và âm thanh, sau đó gửi cảnh báo tới Dashboard Command Center khi phát hiện sự cố nhằm hỗ trợ điều dưỡng phản ứng kịp thời.

Giai đoạn 5: Trợ lý thông dịch tri thức y khoa

Dữ liệu hồ sơ bệnh án và kết quả xét nghiệm được sử dụng làm ngữ cảnh đầu vào cho VNPT Smartbot nâng cao (API 4.2). Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) xử lý thông tin và tạo ra các nội dung giải thích y khoa bằng ngôn ngữ dễ hiểu đối với người bệnh. Các phản hồi này được hiển thị trực tiếp trên ứng dụng di động, hỗ trợ người bệnh tra cứu kết quả xét nghiệm, hiểu rõ tình trạng sức khỏe và tiếp cận thông tin y tế một cách thuận tiện hơn.

Lớp đo lường hành vi số (Tích hợp SmartUX API 7.1)

Thay vì cải tiến giao diện dựa trên các phỏng đoán chủ quan, EyeCU thiết lập một kiến trúc đo lường hành vi vi mô (Micro-Behavioral Tracking Architecture) vận hành ngầm, biến mọi thao tác của nhân viên y tế thành dữ liệu định lượng thông qua 5 kỹ thuật cốt lõi:

1. **Triết lý tích hợp phi xâm nhập (Event Delegation):** Hệ thống áp dụng cơ chế Ủy quyền sự kiện, gán một trình lắng nghe (listener) duy nhất tại tầng cao nhất của DOM thay vì từng nút bấm cục bộ. Khi phát sinh tương tác, thuật toán tự động duyệt ngược cây DOM để tìm định danh `data-ux-id`. Kỹ thuật này giúp thu thập toàn bộ dữ liệu hành vi mà không can thiệp (Zero-Friction) vào logic nghiệp vụ lõi của hệ thống phần mềm.
2. **Cơ chế mô phỏng Eye-Tracking quang học (Dwell Time Measurement):** Thuật toán bắt cặp chuỗi sự kiện `mouseover` và `mouseleave` kết hợp dấu thời gian (timestamp) để đo lường chuẩn xác thời gian con trỏ lưu lại tại một phân vùng. Lớp lọc nhiễu tự động loại bỏ các vi tương tác vô tình ($\leq 300\text{ms}$), giúp xác định chính xác các điểm nóng thu hút sự chú ý (Gaze) lâu nhất trên màn hình của điều dưỡng.
3. **Phân tích điểm nhấn nhận thức (Rage-Click Detection):** Hệ thống theo dõi và phát hiện các thao tác có tính chất chu kỳ lặp lại với cường độ cao (≥ 3 lần click liên tiếp vào cùng một tọa độ trong chu kỳ 600ms). Đây là chỉ báo định lượng trực tiếp cho sự thất vọng (Frustration) của người dùng, giúp đội ngũ lập tức khoanh vùng các chức năng phản hồi chậm hoặc gây hiểu lầm.
4. **Kiến trúc luồng dữ liệu bất đồng bộ (Event Buffering & Batch Flush):** Nhằm triệt tiêu rủi ro thất cổ chai băng thông mạng LAN tại bệnh viện, toàn bộ sự kiện UX được đóng gói ngầm vào bộ đệm trên bộ nhớ tạm (In-memory Buffer). Khối dữ liệu chỉ được giải phóng và đẩy về API Gateway theo lô (Batch Flush) mỗi 10 giây, hoặc bị cưỡng bức gửi đi khi người dùng thoát trang.
5. **Định lượng hóa Trải nghiệm bằng Mô hình Toán học (UX Risk Score):** Máy chủ trung tâm ứng dụng hàm số tối ưu để tổng hợp dữ liệu hành vi thô thành Chỉ số Rủi ro Trải nghiệm ($UXRisk \in [0, 1]$) theo thời gian thực:

$$UXRisk = 0.5 \cdot \frac{RageClicks}{TotalClicks} + 0.3 \cdot \left(1 - \frac{\min(AvgDwell, 3000)}{3000}\right) + 0.2 \cdot \frac{NavigationCount}{20}$$

Trong đó, các biến số phản ánh từng khía cạnh bất ổn của giao diện:

- **Trọng số 0.5 (Rage ratio):** Tỷ lệ thao tác thất vọng trên tổng số tương tác.

- **Trọng số 0.3 (Dwell factor):** Thời gian dừng mắt trung bình ($AvgDwell$) càng ngắn so với định mức chuẩn (3000ms), rủi ro thao tác sai lệch do giao diện khó hiểu càng cao.
- **Trọng số 0.2 (Nav factor):** Số lượt chuyển trang ($NavigationCount$) vượt ngưỡng (20 lượt) là cảnh báo đỏ cho thấy kiến trúc thông tin đang bị phân mảnh.

Khi chỉ số $UXRisk$ tiệm cận 1, hệ thống sẽ tự động phát cảnh báo yêu cầu đội ngũ thiết kế phải tiến hành tái cấu trúc (Redesign) điểm chạm đó ngay lập tức nhằm bảo vệ an toàn vận hành.

3 Hành trình trải nghiệm song song (Dual-User Journey)

Hành trình 1 — Kíp trực Điều hành & Bác sĩ Lâm sàng

Theo dòng thời gian tuyến tính của một ca cấp cứu thực tế tại Hà Nội.

ĐIỂM CHẠM 1 — Tiếp cận từ xa

(Cách viện 1,8km)

- *Phương thức truyền thống:* Luồng thông tin tiền lâm sàng thường mang tính bị động. Kíp trực có ít thời gian để chuẩn bị hạ tầng và y cụ do dữ liệu bệnh nhân chỉ được tiếp nhận đầy đủ khi xe cấp cứu đã cập bến.
- *Tối ưu hóa với EyeCU:* Xe cấp cứu hiển thị trên bản đồ nền thực tế (OpenStreetMap, tích hợp GPS Galileo) kèm bộ đếm ETA. Ngay trên xe, nhân viên y tế đọc số CCCD để hệ thống lập tức kích hoạt **Hồ sơ tốc hành (Pre-admission)**: toàn bộ tiền sử bệnh lý và cảnh báo rủi ro (VD: *Cảnh báo dị ứng Penicillin*) được đồng bộ và hiển thị trực quan trên màn hình trực ban.

ĐIỂM CHẠM 2 — Tiếp nhận tại cổng viện

($T = 0$ giây)

- *Phương thức truyền thống:* Quy trình xác thực an ninh và mở rào chắn bằng phương pháp cơ học thường tạo ra một khoảng trễ hành chính, làm hao hụt "thời gian vàng" của người bệnh.
- *Tối ưu hóa với EyeCU:* Camera AI nhận diện biển số và xác thực luồng ưu tiên trong **dưới 3,2 giây** (độ tin cậy 99,2%). Hệ thống tự động kích hoạt chuỗi IoT song song: mở rào chắn, bật đèn LED dẫn đường, hạ nhiệt độ phòng cấp cứu về 24°C và chuyển máy thở sang trạng thái sẵn sàng.¹

ĐIỂM CHẠM 3 — Khám bệnh lâm sàng tại giường

- *Phương thức truyền thống:* Thao tác nhập liệu văn bản trên hệ thống EMR đòi hỏi bác sĩ phải phân chia sự tập trung giữa màn hình máy tính và việc giao tiếp trực tiếp với bệnh nhân.
- *Tối ưu hóa với EyeCU:* Bác sĩ thăm khám hoàn toàn **rảnh tay**. SmartVoice STT (API 3.2 & 3.3) thu âm và chuyển đổi giọng nói thành văn bản theo luồng streaming. Bộ NLP Parser tự động phân rã ngữ nghĩa và điền chuẩn xác vào cấu trúc **SOAPE**: Lý do vào viện (S) → Khám lâm sàng (O) → Chẩn đoán (A) → Y lệnh (P) → Đánh giá lại (E).

ĐIỂM CHẠM 4 — Giám sát nội trú ban đêm

(Privacy-by-Design)

- *Phương thức truyền thống:* Giám sát qua camera thông thường đòi hỏi nhân sự túc trực màn hình liên tục 24/7 và luân phiên ẩn các quan ngại pháp lý về việc xâm phạm quyền riêng tư hình ảnh của người bệnh.

¹Chuỗi kích hoạt IoT (barrier, đèn LED, điều hòa) là thiết kế kiến trúc tích hợp qua cổng HL7/FHIR trong lộ trình triển khai thực địa; phần demo MVP hiện thực hóa luồng LPR và gửi thông báo OTT.

- *Tối ưu hóa với EyeCU*: Camera giám sát **chỉ trích xuất khung xương đồ họa** (Skeleton tracking), triệt tiêu rủi ro lộ lọt hình ảnh đời tư. Khi biểu thức logic nhận diện ngã kết hợp tiếng va đập/kêu cứu vượt ngưỡng ($RI > 0,75$, Sensor Fusion: SmartVision 8.1 + SmartVoice 3.2), hệ thống kích hoạt **Chỉ huy đa sự cố (Multi-Grid Alert)**: đẩy camera sự cố lên top, chớp đỏ viền và gửi OTT điều động kịp trực dưới 5 giây.

Hành trình 2 — Người bệnh & Người nhà (Giao diện Di động)

Thiết kế hướng tới sự tiếp cận bình đẳng (Accessibility) và triệt tiêu rào cản công nghệ (Zero-Friction) cho nhóm người dùng cao tuổi.

ĐIỂM CHẠM 1 — Tiếp cận không rào cản (Zero-Download Onboarding)

- *Phương thức truyền thống*: Việc yêu cầu cài đặt các ứng dụng y tế gốc (Native App) buộc bệnh nhân phải trải qua quy trình tìm kiếm, tải xuống và đăng ký tài khoản phức tạp, tạo ra rào cản tiếp cận lớn đối với tệp người dùng lớn tuổi.
- *Tối ưu hóa với EyeCU*: Người dùng chỉ cần sử dụng tính năng camera cơ bản (hoặc Zalo) để quét mã QR in trên sổ khám. Nền tảng Web App Responsive sẽ khởi chạy tức thì, tự động điều chỉnh hiển thị mượt mà trên mọi kích thước màn hình mà không yêu cầu bất kỳ thao tác cài đặt bổ sung nào.

ĐIỂM CHẠM 2 — Trực quan hóa & Thông dịch y khoa

- *Phương thức truyền thống*: Bệnh nhân thường nhận lại kết quả xét nghiệm (PDF/giấy in) dưới dạng dữ liệu thô chứa nhiều thuật ngữ hóa sinh chuyên sâu. Khoảng trống thông tin này không chỉ làm giảm hiệu quả theo dõi bệnh lý mà còn gia tăng áp lực tư vấn lặp lại lên đội ngũ bác sĩ.
- *Tối ưu hóa với EyeCU*: Các chỉ số hóa sinh lập tức được **trực quan hóa qua thanh đo màu sắc** (Bình thường — Chú ý — Cảnh báo). Tích hợp cùng Smartbot nâng cao 4.2 (LLM), hệ thống tự động thông dịch dữ liệu y khoa thành lời khuyên thường thức qua giao diện hội thoại: "*Chỉ số đường huyết của bác đang ở mức chú ý, bác nên cân nhắc giảm lượng tinh bột trong các bữa ăn...*", giúp người bệnh chủ động thấu hiểu tình trạng sức khỏe.

ĐIỂM CHẠM 3 — Chốt chặn an toàn tối hậu (Emergency SOS)

- *Phương thức truyền thống*: Nút chuông gọi điều dưỡng (Nurse Call) thường được gắn cố định bằng vật lý tại đầu giường, khiến người bệnh mất khả năng phát tín hiệu ứng cứu khi di chuyển ra các khu vực khác (hành lang, nhà vệ sinh).
- *Tối ưu hóa với EyeCU*: Nút SOS khẩn cấp được **ghim cố định (pinned)** tại vùng ngón tay cái dễ thao tác nhất ở đáy màn hình, kết hợp hiệu ứng nhịp tim động. Để triệt tiêu rủi ro chạm nhầm gây nhiễu loạn kịp trực, hệ thống tích hợp cơ chế **Đếm ngoại hủy lệnh (3-second Undo Delay)** kèm phản hồi rung haptic. Khi chạm nhầm, người bệnh có 3 giây để ấn "Hủy". Nếu bỏ qua, tín hiệu sẽ lập tức vượt mọi khâu trung gian, kích hoạt báo động đỏ trực tiếp về Trạm chỉ huy.

4 Ma trận tổng hợp điểm chạm công nghệ VNPT

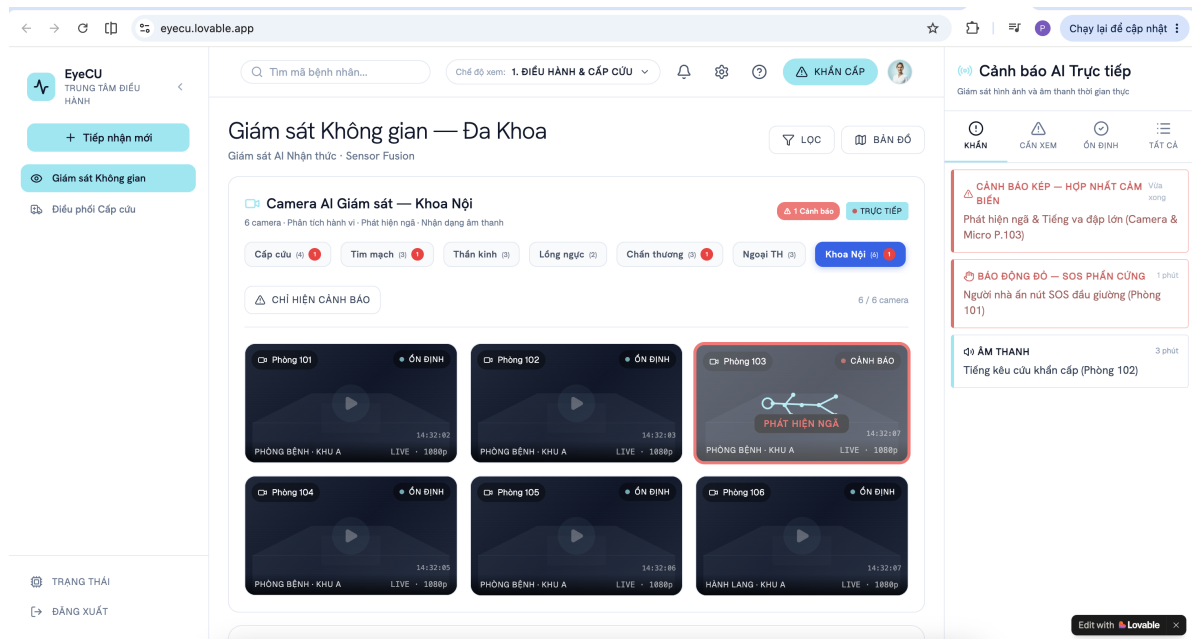
Bảng ma trận dưới đây tổng hợp dòng chảy tương tác, minh chứng cho sự liên kết chặt chẽ giữa Trải nghiệm người dùng (UX) và năng lực xử lý ngầm của hệ sinh thái API VNPT:

Phân hệ trải nghiệm	Kịch bản lâm sàng thực tế	API VNPT chạy ngầm tương ứng	Chỉ số Tác động & Tối ưu vận hành
1. Tiếp nhận & Điều phối	Xe cấp cứu tiếp cận cổng nội khu; Nhân viên y tế truyền phát mã định danh (CCCD) từ xa.	SmartVision 8.2 (Nhận diện biển số LPR).	Rút ngắn độ trễ hành chính (Administrative latency) từ 5-7 phút xuống < 60 giây.
2. Số hóa hồ sơ & Định danh	Điều dưỡng chụp ảnh/quét phiếu chuyển tuyến; Thực hiện đối chiếu sinh trắc học bệnh nhân.	SmartReader 5.2 (OCR hóa sinh thô); VNPT eKYC 1.3 (So khớp khuôn mặt).	Triệt tiêu rủi ro sai lệch định danh (False ID); Số hóa dữ liệu giấy sang định dạng JSON cấu trúc trong < 5 giây.
3. Khám bệnh lâm sàng	Bác sĩ thực hiện thủ thuật lâm sàng và đọc y lệnh thành tiếng qua microphone.	SmartVoice 3.2 (STT luồng streaming) & SmartVoice 3.3 (Tóm tắt/NLP parsing).	Trải nghiệm khám rảnh tay (Hands-free UX); Tiết kiệm ~ 2.5 giờ công (FTE) nhập liệu hành chính mỗi ca trực.
4. Giám sát nội trú ban đêm	Phát sinh sự cố té ngã (Fall detection) hoặc âm thanh kêu cứu khẩn cấp vượt ngưỡng.	SmartVision 8.1 (Pose Skeleton) & 8.3 (Nhận diện khuôn mặt); SmartVoice 3.2 (Bắt từ khóa).	Triệt tiêu điểm mù giám sát; Cơ chế hợp nhất cảm biến (Sensor Fusion) giảm thiểu tối đa tỷ lệ báo động giả (False Positive Rate).
5. Thông dịch tri thức y khoa	Bệnh nhân tra cứu kết quả hóa sinh hoặc đơn thuốc điện tử qua Web App di động.	Smartbot nâng cao 4.2 (Trợ lý hỏi đáp ứng dụng LLM Y khoa).	Tối ưu hóa tính tiếp cận (Accessibility) cho người cao tuổi; Tăng 30% hiệu suất luồng tư vấn lâm sàng.
6. Đo lường hành vi số	Hệ thống thu thập các tương tác vi mô (Rage-click, Dwell-time) của nhân viên y tế trên EMR Dashboard.	VNPT SmartUX SDK 7.1 (Tích hợp phi xâm nhập đo lường vi mô).	Định lượng UX Risk Score; Thiết lập cơ sở dữ liệu thực chứng (Data-driven) để liên tục tái cấu trúc luồng công việc.

5 Hình ảnh Wireframe/Mockup giao diện

Hiện thực hóa triết lý thiết kế “Lấy người dùng làm trung tâm” (User-Centric Design), bộ giao diện của EyeCU được phát triển theo hai luồng trải nghiệm độc lập, đảm bảo khả năng tiếp cận tối đa cho từng nhóm đối tượng chuyên biệt.

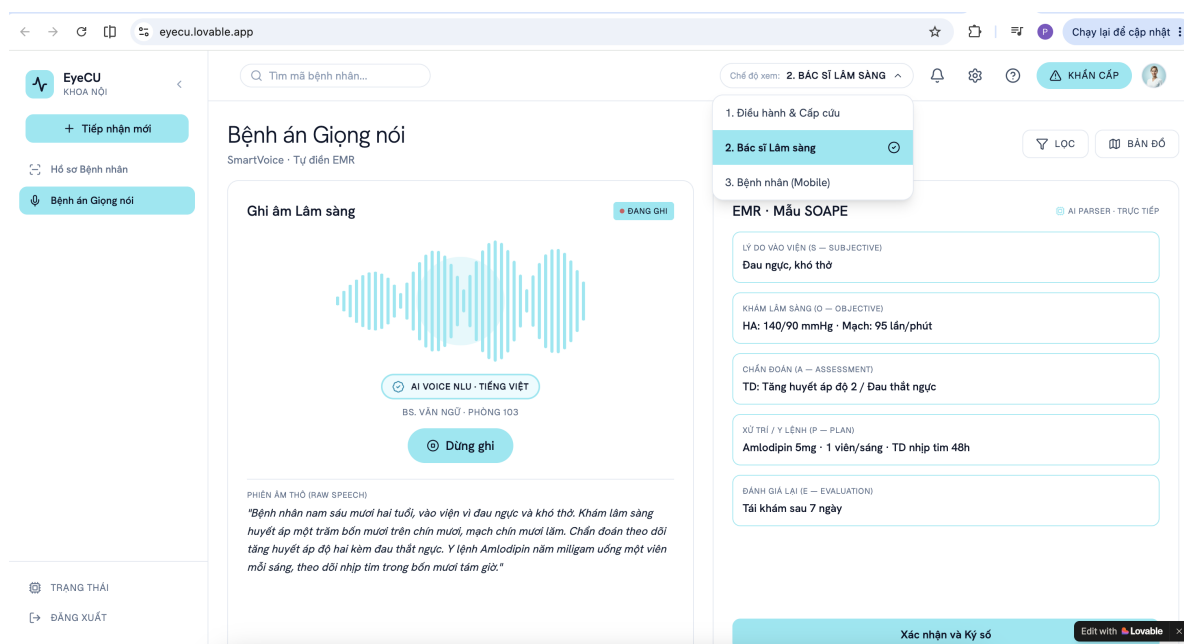
1. Giao diện Command Center (Trạm chỉ huy dành cho Điều dưỡng nội trú)



Hình 2: Giao diện Màn hình Command Center dành cho Điều dưỡng và Ops trực ca

- **Trực quan hóa Dữ liệu không gian (Spatial Data Visualization):** Khu vực trung tâm hiển thị sa bàn kỹ thuật số mô phỏng mặt bằng phòng bệnh thực địa. Hệ thống lược bỏ hoàn toàn các luồng video thô không cần thiết, thay vào đó ứng dụng cơ chế Cảnh báo mã hóa màu dựa trên Chỉ số Rủi ro Nhận thức (*RI*), hỗ trợ bao quát trạng thái toàn khoa cùng lúc.
- **Cảnh báo Động & Cơ chế Hợp nhất Cảm biến (Sensor Fusion):** Ngay khi thuật toán phát hiện sự cố, phân vùng phòng bệnh tương ứng lập tức kích hoạt hiệu ứng nhấp nháy biên độ cao (Neon Red Alert). Tính năng lõi *Sensor Fusion* tự động hợp nhất tín hiệu thị giác (Xương người dùng phục dựng - Skeleton overlay) và thính giác (Biểu đồ phổ âm thanh - Spectrogram) thời gian thực, đưa ra cảnh báo kép chuẩn xác kèm các nút thao tác nhanh (Quick Actions) nhằm tối ưu hóa phản ứng lâm sàng với độ trễ tiệm cận không.
- **Bảo vệ Quyền riêng tư nghiêm ngặt (Privacy-by-Design):** Toàn bộ luồng camera giám sát tại phòng nội trú đều được tự động ẩn danh hóa, che mờ mặt hoặc chỉ hiển thị cấu trúc khung xương đồ họa, đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật khắt khe nhất của ngành y tế.

2. Giao diện Phân hệ Bệnh án Giọng nói (Dành cho Bác sĩ Lâm sàng)



Hình 3: Giao diện Phân hệ Bệnh án Giọng nói dành cho Bác sĩ Lâm sàng

- **Cấu trúc Phân vùng Không gian (Asymmetric Interface Grid):** Giao diện được tổ chức theo triết lý *Hands-free UI (Khám bệnh rảnh tay)* với bố cục chia đôi màn hình độc lập. Sự sắp xếp này tối ưu hóa việc phân tách giữa luồng xử lý thu âm trực tiếp và luồng hiển thị kết quả dữ liệu cấu trúc, giúp giảm tối đa tải trọng nhận thức cho nhân viên y tế trong quá trình thao tác.
- **Widget Kiểm soát và Thu nhận Âm thanh (Acoustic Control Panel):** Đặt tại không gian bên trái, tích hợp đồ thị sóng âm động (*Audio Waveform Visualizer*) hiển thị trực quan tần số âm thanh đầu vào thời gian thực, đi kèm hệ thống chip chỉ báo trạng thái ghi âm ngầm, thông tin phân quyền tài khoản chuyên khoa hiện hành và hệ thống nút tương tác thay đổi trạng thái tác vụ kích thước lớn, dễ thao tác.
- **Khung Phản hồi Phiên âm tự động (Dynamic Transcript Sub-panel):** Bố trí ngay bên dưới widget kiểm soát âm thanh, đóng vai trò là bảng ghi nhận thô tích hợp (*Raw Speech Box*). Toàn bộ dòng hội thoại và y lệnh đọc thành tiếng của bác sĩ sẽ lập tức được mô hình chuyển đổi ngôn ngữ trích xuất trực tiếp thành chuỗi văn bản Tiếng Việt liên tục một cách trực quan trước khi đưa vào bộ lọc xử lý ngữ nghĩa.
- **Bảng Hồ sơ cấu trúc hóa (Structured EMR Metadata Component):** Chiếm trọn không gian bên phải giao diện, phân rã thông tin động chuẩn hóa theo mô hình bệnh án **SOAP**. Các phân mục thông tin bao gồm lý do vào viện (S), khám lâm sàng (O), chẩn đoán (A), xử trí / y lệnh (P), và đánh giá lại (E) được đóng gói trong các khối thẻ bo góc độc lập, hỗ trợ phân loại dữ liệu rõ ràng, dễ bao quát.
- **Cơ chế Đồng bộ trực tiếp và Điểm chạm Tối ưu (AI Parsing & Workflow Mapping):** Góc trên bên phải của biểu mẫu tích hợp nhân chỉ báo phân tích trực tiếp (*Real-time AI Parser*) thể hiện trạng thái hoạt động ngầm của mô hình bóc tách thực thể y khoa (NLU). Khi dữ liệu chữ thô xuất hiện bên cột trái, thuật toán tự động bẻ nhánh, định tuyến và điền ngầm (*Auto-fill*) vào các trường thông tin biểu mẫu tương ứng ở cột phải. Quy trình được khép kín bằng hệ thống nút hành động trọng tâm kích thước lớn tại đáy màn hình để xác

nhận hồ sơ và thực hiện ký số, triệt tiêu hoàn toàn gánh nặng nhập liệu cơ học bằng bàn phím.

3. Giao diện EyeCU App (Dành cho Người bệnh và Người nhà)



Hình 4: Giao diện Ứng dụng Di động EyeCU App tích hợp Trợ lý ảo AI dành cho Người bệnh

- **Giao diện Tối giản & Tăng cường Khả năng tiếp cận:** Giao diện di động được tinh giản hóa tối đa cấu trúc đồ họa, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng nhiễu loạn thông tin. Phông chữ kích thước lớn và độ tương phản màu sắc được tính toán kỹ lưỡng để phù hợp với năng lực nhận thức cũng như thị lực của nhóm người dùng cao tuổi.
- **Thực quan hóa Chỉ số Hóa sinh:** Chuyển đổi các bảng biểu kết quả xét nghiệm phức tạp thành các thẻ chỉ số trực quan (Glucose, Cholesterol, Creatinine, HbA1c...). Các chỉ số vượt ngưỡng nguy hiểm sẽ được hệ thống tự động định tiến trên thang đo màu sắc trực quan (Bình thường - Chú ý - Cảnh báo), giúp người bệnh dễ dàng tự nhận thức trạng thái sức khỏe cá nhân.
- **Trợ lý Hội thoại LLM Tích hợp Giọng nói:** Khung hội thoại AI (Tích hợp API Smartbot nâng cao 4.2) thay thế các thuật ngữ chuyên môn bằng ngôn ngữ thường thức, thân thiện. Khả năng tương tác hai chiều hoàn toàn bằng Giọng nói giúp loại bỏ hoàn toàn rào cản thao tác gõ phím phức tạp đối với người già.
- **Cơ chế Phản ứng Khẩn cấp (SOS):** Nút SOS khẩn cấp được thiết kế kích thước lớn, định vị cố định tại vùng đáy màn hình với hiệu ứng nhịp tim động (Pulse Animation). Khi

kích hoạt, tín hiệu cứu trợ lập tức bỏ qua mọi bước trung gian để đồng bộ thẳng về Trạm chỉ huy của khoa, đóng vai trò như chốt chặn an toàn tối hậu bảo vệ tính mạng người bệnh tại thực địa.

III TÍNH ĐỔI MỚI VÀ KHÁC BIỆT CỐT LÕI

1 Bảng so sánh và định lượng tính vượt trội của giải pháp

Phân hệ cốt lõi	Phần mềm Y tế hiện hành (VNPT HIS, Medpro)	Các thư viện Open-source rời rạc (YOLOv8, Whisper)	Hệ điều hành EyeCU (Giải pháp của nhóm)
Bản chất vận hành	Thụ động (Static): Con người phải chủ động ngồi gõ bàn phím nhập dữ liệu.	Đơn nhiệm, không hỗ trợ luồng vận hành y tế chuyên sâu.	Nhận thức không gian: Tự nghe, tự nhìn và vận hành chạy ngầm tự động.
Cơ chế cấp cứu	Thủ công, thông tin truyền đạt rời rạc qua bộ đàm/điện thoại bàn.	Không có năng lực liên kết điều khiển phần cứng IoT.	Kíp trực kích hoạt hạ tầng chủ động: LPR Camera nhận diện biển số, tự động gửi OTT điều phối kíp trực và phát tín hiệu kích hoạt thiết bị (barrier, thang máy) qua cổng IoT - giảm thời gian chuẩn bị từ 5-7 phút xuống < 60s.
Phòng thủ an toàn	Điểm mù ban đêm. Bệnh nhân bất động không thể với tới nút bấm cơ học.	Có nhận diện tư thế nhưng tỷ lệ báo động giả cao do nhiễu bối cảnh.	Xác thực đa phương thức: Phối hợp chéo Thị giác (tư thế ngã) và Thính giác (tiếng kêu cứu) triệt tiêu báo động giả.
Xử lý & Thông dịch Dữ liệu	Chỉ trả file cứng hoặc bản PDF thô, thuật ngữ chuyên môn gây quá tải luồng tư vấn.	Nhận dạng tiếng Việt phổ thông tốt, nhưng không thể xử lý chính xác thuật ngữ y khoa chuyên sâu và thiếu lớp NLU để tự động điền cấu trúc EMR.	Thông dịch tri thức LLM: Ứng dụng LLM (Smartbot 4.2) dịch nghĩa chỉ số thô thành ngôn ngữ thường thức và tự động phân tách EMR.
Đo lường trải nghiệm vận hành (UX)	Không có cơ chế đo lường hành vi. Cải tiến giao diện hoàn toàn dựa trên phỏng đoán chủ quan.	Không có tầng ứng dụng giao diện (UI), không có cơ chế thu thập và đo lường UX.	Tích hợp VNPT SmartUX (API 7.1): Đo lường Dwell-time, Rage-click và tính UX Risk Score thời gian thực - làm cơ sở tối ưu luồng công việc điều dưỡng liên tục.

Bảng 2: Bảng đối chiếu minh chứng tính ưu việt $\geq 30\%$ tại các phân hệ cốt lõi

2 Điểm đổi mới mang tính bản chất giải pháp (Tính sáng tạo)

- **Chiến lược Zero-Friction (Tương tác không chạm):** Trái ngược với các hệ thống HIS hiện hành vô tình biến y bác sĩ thành "nhập liệu viên", EyeCU cắt giảm toàn bộ thao tác vật lý thông qua hai cơ chế lõi: (1) *Bệnh án rảnh tay:* Bác sĩ đọc y lệnh lâm sàng, hệ thống

ứng dụng SmartVoice (API 3.2) chuyển đổi giọng nói thành văn bản, tự động phân tích cú pháp NLP và điền chính xác vào từng cấu trúc trường SOAPE của EMR theo thời gian thực mà không cần gõ phím; (2) *Số hóa hồ sơ giấy*: Điều dưỡng chỉ cần chụp ảnh phiếu khám, SmartReader (API 5.2) tự động bóc tách toàn bộ chỉ số hóa sinh thành dữ liệu JSON có cấu trúc. Chiến lược này ước tính cắt giảm 65% thời gian nhập liệu hành chính mỗi ca trực, hoàn trả quỹ thời gian quý giá để đội ngũ y tế trực tiếp chăm sóc lâm sàng.

- **Lợi thế bản địa hóa sâu sắc (Hyper-Localization):** Điểm yếu chí mạng của các mô hình ngữ nghĩa tổng quát (như Whisper của OpenAI) là sự đứt gãy ngữ nghĩa trong các môi trường đặc thù. Bằng việc tích hợp sâu bộ lõi VNPT SmartVoice, EyeCU mang lại độ chính xác vượt trội trong các ngữ cảnh mà AI ngoại nhập chưa được tối ưu: khả năng nhận diện phương ngữ vùng miền (giọng Nghệ An, Huế, Nam Bộ), bắt chuẩn xác các từ khóa kêu cứu ngặt quăng trong trạng thái hoảng loạn, và thấu hiểu thuật ngữ y khoa viết tắt đặc thù của hệ thống bệnh viện Việt Nam. Sự ưu việt này giúp triệt tiêu bài toán báo động giả (False Positives), thiết lập tiêu chuẩn an toàn mới cho y tế nội trú.
- **Data-driven UX Optimization (Tối ưu giao diện bằng dữ liệu thực chứng):** EyeCU là giải pháp y tế tiên phong nhúng trực tiếp lớp đo lường hành vi số (VNPT SmartUX - API 7.1) vào bảng điều khiển lâm sàng (Clinical Dashboard). Thay vì cải tiến UI/UX dựa trên các phỏng đoán chủ quan, hệ thống tự động theo dõi và tính toán Chỉ số Rủi ro Trải nghiệm (*UX Risk Score*) theo thời gian thực từ dữ liệu điểm nhấn thao tác (Rage-click), thời gian dừng mắt (Dwell-time), và tần suất điều hướng. Bộ chỉ số định lượng khách quan này là kim chỉ nam để đội ngũ phát triển liên tục tối ưu hóa luồng công việc điều dưỡng sau mỗi ca trực, đảm bảo hệ thống giảm thiểu tối đa gánh nặng nhận thức trong các tình huống sinh tử.

IV PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI & TÍNH KHẢ THI KỸ THUẬT

1 Nguồn dữ liệu giả lập

Nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phát triển sản phẩm MVP mà không vi phạm các tiêu chuẩn về bảo mật thông tin và quyền riêng tư của dữ liệu y tế, chúng tôi thiết lập Chiến lược Dữ liệu giả lập tự sinh (Synthetic Data Strategy) làm phương án thực thi cốt lõi. Chúng tôi dự kiến xây dựng hệ thống dữ liệu input kiểm thử hợp pháp 100% dựa trên ba nguồn chính:

- Thứ nhất, sử dụng Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để tạo sinh tập dữ liệu gồm 2.000 cuộc hội thoại y tế giả lập giữa y bác sĩ và bệnh nhân, chứa các cấu trúc đan xen ngôn ngữ Anh - Việt (Code-switching) nhằm huấn luyện và thử nghiệm bộ não trợ lý ảo.
- Thứ hai, ứng dụng các thư viện lập trình như Python Faker để sinh tự động hệ thống 10,000 dòng log hành vi giả lập (bao gồm các trường dữ liệu về mốc thời gian, ID giường bệnh, loại cảm biến và trạng thái hạ tầng) để chạy thử nghiệm và tối ưu hóa các thuật toán logic rẽ nhánh, điều phối dòng chảy dữ liệu trên backend.
- Thứ ba, đối với mô-đun thị giác máy tính, nhóm sẽ tự sản xuất các video mô phỏng tư thế ngã dựa trên kịch bản dựng sẵn do chính các thành viên trong đội ngũ thực hiện. Phương án này cho phép EyeCU sở hữu nguồn dữ liệu sạch, có độ kiểm soát cao để tinh chỉnh mô hình nhận diện tư thế mà không phụ thuộc vào dữ liệu thực tế của bệnh nhân.

2 Kỹ thuật Build/Deploy khả thi và Cơ chế dự phòng sự cố (Fallback)

2.1 Giải pháp đóng gói Docker Container và Kiến trúc tích hợp mở

Để đảm bảo tính độc lập về môi trường, tối ưu hóa tài nguyên phần cứng và đáp ứng nghiêm ngặt tiêu chí kiểm thử tự động của Ban Tổ chức, toàn bộ hệ thống Backend và bộ dịch mã Core Engine

của EyeCU được đóng gói toàn diện dưới dạng Docker Container và phân phối qua Docker Hub.

2.1.1 Cam kết chuẩn triển khai Đơn-lệnh (One-Command Deployment):

Nhóm cam kết cung cấp tệp cấu hình `docker-compose.yml` cùng mã kịch bản khởi chạy tự động (Shell Script). Ban Giám khảo có thể thiết lập toàn bộ môi trường phục vụ công tác demo/kiểm thử chỉ với 01 câu lệnh duy nhất:

```
docker-compose up --build -d
```

Giải pháp này đảm bảo tính đóng gói tuyệt đối, triệt tiêu xung đột thư viện nền và cam kết vượt qua các bài kiểm tra cài đặt tự động lặp lại liên tục ≥ 3 lần từ Ban Tổ chức tại Vòng 2 không phát sinh lỗi hệ thống.

2.1.2 Kiến trúc tích hợp Plug-and-Play:

Tầng Backend (FastAPI/Python) thiết kế các module kết nối mở, sẵn sàng tích hợp trực tiếp vào hệ thống quản lý bệnh viện truyền thống (VNPT HIS) hoặc bệnh án điện tử (EMR) sẵn có thông qua các cổng API tiêu chuẩn y tế quốc tế là HL7 (Health Level Seven) và FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources). Cơ chế này đảm bảo dữ liệu bóc tách được đồng bộ hai chiều thời gian thực mà hoàn toàn không làm xáo trộn, gián đoạn hay đòi hỏi cấu trúc lại hạ tầng phần mềm cũ của cơ sở y tế.

2.2 Cơ chế dự phòng sự cố thực địa tại Biên (Local Edge Fallback Mechanism)

Nhằm phòng ngừa rủi ro bất khả kháng từ môi trường mạng như: nghẽn mạng Internet quốc tế, đứt cáp quang, hoặc mất kết nối tạm thời đến hệ thống trục API Cloud Gateway của VNPT, EyeCU thiết lập một kiến trúc dự phòng chủ động tại chỗ (*Privacy & Fallback Design*):

2.2.1 Chế độ vận hành Local Edge ngoại tuyến (Offline Mode):

Khi mất kết nối Cloud, mạch giám sát trạng thái (Heartbeat Monitor) cài đặt ngầm tại máy chủ biên bệnh viện sẽ lập tức chuyển đổi luồng xử lý sang chế độ mạng nội bộ (Mạch LAN LAN-only). Hệ thống ngắt các request gọi API đám mây và kích hoạt các thuật toán Computer Vision rút gọn (Tiny-YOLOv8 & Pose Estimation tinh chỉnh) xử lý trực tiếp luồng RTSP từ camera ngay tại local để duy trì năng lực phát hiện tư thế ngã.

2.2.2 Kích hoạt hạ tầng phần cứng vật lý khẩn cấp:

Trong trạng thái Fallback, toàn bộ các lệnh điều phối hành chính được chuyển hóa thành các xung tín hiệu điều khiển phần cứng nội bộ thông qua giao thức TCP/IP hoặc các mạch rơ-le kết nối mạng LAN:

- Cường bức mở toàn bộ hệ thống barrier tại cổng viện để xe cấp cứu ra vào tự do không cần quét biển số.
- Phát tín hiệu ưu tiên, tự động gọi và giữ cabin thang máy trống tại tầng trệt phục vụ kịp trực trực chiến.
- Chuyển luồng cảnh báo sự cố ngã/tiếng động bất thường từ giao diện web/app sang hệ thống Còi hú vật lý kết nối dây và bảng đèn LED chỉ thị lắp đặt trực tiếp tại phòng trực ca trực đêm của điều dưỡng.

Cơ chế Fallback khép kín này đảm bảo hệ thống y tế vận hành liên tục 24/7 với độ sẵn sàng cao (Availability $\geq 99.9\%$), bảo vệ an toàn mạng sống tuyệt đối cho bệnh nhân cao tuổi trong mọi tình huống khủng hoảng hạ tầng mạng.

3 Ước tính chi phí hạ tầng và Vận hành tối ưu

Nhằm triệt tiêu gánh nặng chi phí đầu tư hạ tầng phần cứng ban đầu cho các cơ sở y tế, EyeCU áp dụng triệt để mô hình Hạ tầng siêu nhẹ (*Asset-Light*) thông qua cơ chế xử lý phân tán ngầm: Tận dụng tối đa hệ thống Camera IP và Micro sẵn có tại thực địa, chuyển dịch toàn bộ tác vụ xử lý thị giác máy tính nặng (như bóc tách tọa độ khung xương - Skeleton Extraction) về thiết bị biên (Edge) đặt tại bệnh viện.

Máy chủ trung tâm trên Cloud sẽ đóng vai trò xử lý tính toán logic, chỉ tiếp nhận các gói tin định dạng chuỗi văn bản (Text String) hoặc ma trận tọa độ (Skeleton JSON Payload) đã được tinh gọn để tối ưu hóa băng thông đường truyền và chi phí tài nguyên máy chủ đám mây.

Dựa trên biểu phí dịch vụ hạ tầng điện toán đám mây (Cloud Compute) và biểu phí hạn mức API thực tế trên thị trường, chi phí vận hành tối ưu cho quy mô phân hệ thử nghiệm tiêu chuẩn gồm 50 giường bệnh nội trú được định lượng chi tiết theo bảng dưới đây:

STT	Cấu phần hạ tầng & Dịch vụ	Chi tiết cấu hình kỹ thuật tiêu chuẩn	Tần suất tiêu thụ / Khối lượng (Dự kiến/Tháng)	Đơn giá niêm yết môi tháng (VNĐ)
1	Cloud Compute Engine (Máy chủ trung tâm)	16 vCPU Core / 32 GB RAM / 200 GB SSD NVMe Storage / Băng thông mạng nội địa 100 Mbps chuyên dụng (Gói SMC 09 niêm yết chính thức của VNPT Smart Cloud)	Vận hành liên tục 24/7/365	4.399.000 (12)
2	Bộ nhớ đồ họa bổ sung (vRAM)	Cấu hình thêm bộ nhớ vRAM đám mây nhằm tăng tốc độ tính toán cho luồng thuật toán nhận diện tư thế ngã và số hóa dữ liệu.	02 GB (89.000 VNĐ / GB) (12)	178.000
3	Băng thông bổ sung trong nước	Bổ sung dải băng thông chia sẻ ở trong nước nhằm cam kết luồng truyền tải dữ liệu hệ thống và video phòng bệnh liên tục không trễ.	02 Block 50Mbps (350.000 VNĐ / Block) (13)	700.000
4	Ổ cứng SSD bổ sung	Khối dung lượng ổ cứng SSD cấu hình thêm phục vụ lưu trữ cơ sở dữ liệu hệ thống và lưu đệm log tương tác vi mô của người dùng.	18 Block 20GB (Tổng 360GB) (148.000 VNĐ / Block) (13)	2.664.000
5	Dung lượng Backup bổ sung	Khối dung lượng cấu hình thêm phục vụ cơ chế đóng gói, sao lưu dự phòng an toàn dữ liệu hệ thống nội bộ định kỳ.	02 Block 20GB (Tổng 40GB) (39.000 VNĐ / Block) (13)	39.000
Tổng chi phí vận hành hệ thống		Quy mô phân hệ thử nghiệm tiêu chuẩn (50 giường bệnh nội trú)	<i>Chi phí chính xác không làm tròn</i>	8.160.000

Bảng 3: Dự toán chi phí hạ tầng vận hành hệ thống EyeCU

4 An toàn thông tin và Bảo mật quyền riêng tư (Privacy by Design)

Do đặc thù nghiêm ngặt của ngành Y tế đối với quyền đời tư của người bệnh, hệ thống EyeCU được thiết kế dựa trên triết lý bảo mật ngay từ kiến trúc và tuân thủ nghiêm ngặt Luật An ninh mạng Việt Nam. Nhóm giải quyết triệt để rủi ro rò rỉ dữ liệu thông qua cấu trúc bảo mật Zero-Retention Pipeline (Trục dọc dữ liệu không lưu trữ) chia làm 3 lớp độc lập:

- **Lớp thứ nhất - Edge Anonymization (Ẩn danh tại biên):** Đối với luồng dữ liệu livestream từ camera phòng bệnh nội trú, hệ thống dự kiến áp dụng thuật toán tự động che mờ khuôn mặt (Blur Face) thông qua API VNPT SmartVision ngay tại thiết bị biên trước khi truyền phát về máy chủ trung tâm. Đồng thời, dữ liệu video đệm phục vụ cho thuật toán nhận diện tư thế ngã chỉ được lưu trữ tạm thời trên RAM và bị xóa sạch hoàn toàn (Zero-Retention) theo chu kỳ sau mỗi 10 giây nếu không có sự cố lâm sàng nào xảy ra.
- **Lớp thứ hai - Data Tokenization (Mã hóa thực thể):** Đối với các dữ liệu bóc tách từ phiếu xét nghiệm hay hồ sơ chuyển tuyến thông qua VNPT SmartReader, toàn bộ thông tin sẽ được mã hóa theo tiêu chuẩn AES-256 và gắn ID ẩn danh. Hệ thống hoàn toàn không lưu trữ trực tiếp các thông tin định danh cá nhân (PII - Personally Identifiable Information) của bệnh nhân như họ tên, số điện thoại hay số CCCD, từ đó triệt tiêu rủi ro bị khai thác dữ liệu từ bên ngoài.
- **Lớp thứ ba - Pháp lý y tế:** Phiên bản MVP của dự án được định vị rõ ràng là chỉ can thiệp và hỗ trợ vào luồng điều phối vận hành hành chính ngoài, không lưu trữ, can thiệp hay sửa đổi phác đồ điều trị chuyên môn của y bác sĩ. Điều này giúp EyeCU đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn thông tin y tế hiện hành mà không làm xáo trộn quy trình chịu trách nhiệm pháp lý của cơ sở y tế.

5 Lộ trình phát triển sản phẩm (Product Roadmap)

Để đảm bảo tính khả thi trong việc đưa một giải pháp công nghệ y tế vào thực tiễn, lộ trình phát triển của EyeCU được phân kỳ thành 3 giai đoạn chiến lược, đi từ kiểm chứng nguyên mẫu đến triển khai tiền trạm tại các bệnh viện công lập tuyến đầu:

Giai đoạn	Thời gian	Trọng tâm Chiến lược	Kết quả Đầu ra (Deliverables)
Giai đoạn 1: Kiểm chứng & MVP (Vòng 1 & 2)	Tháng 06/2026	Thiết lập đường ống dữ liệu bất đồng bộ tích hợp hệ sinh thái API VNPT. Giải quyết rào cản dữ liệu nhạy cảm bằng Chiến lược Dữ liệu giả lập tự sinh (Synthetic Data).	- Hoàn thiện High-Fidelity Interactive MVP. - Đóng gói Backend bằng Docker 1-lệnh, đảm bảo vượt qua các bài kiểm thử tự động của BTC.
Giai đoạn 2: Tối ưu & Thực chiến (Chung kết Hack-AIthon)	Tháng 07/2026	Ứng dụng Data-driven UX: Thu thập và phân tích chỉ số tương tác vi mô từ VNPT SmartUX để tái cấu trúc giao diện, giảm thiểu gánh nặng nhận thức cho điều dưỡng.	- Hoàn thiện Dashboard Trạm chỉ huy. - Demo thực chiến luồng điều phối hạ tầng khẩn cấp (Barrier/Báo động) trước Hội đồng.
Giai đoạn 3: Tiền trạm Tuyển đầu (Hậu cuộc thi)	Tháng 08 - 12/2026	Triển khai mô hình "Đề tài nghiên cứu khoa học" thí điểm (Pilot) tại Khoa Cấp cứu của một bệnh viện tuyến đầu để vượt qua rào cản đầu thầu công.	- Báo cáo thực chứng lâm sàng về hiệu suất cắt giảm "thời gian vàng". - Khớp nối giao thức y tế HL7/FHIR với hệ thống VNPT HIS hiện hữu.

V TÁC ĐỘNG DỰ KIẾN VÀ MÔ HÌNH DOANH THU

1 Định lượng quy mô thị trường mục tiêu (TAM - SAM - SOM) tại Việt Nam

Để chứng minh tiềm năng thương mại hóa và tính khả thi về mặt kinh tế của dự án EyeCU tại thị trường Việt Nam năm 2026, đội ngũ dự án tiến hành phân tích và đo lường dung lượng thị trường theo mô hình phễu định lượng ba lớp chuẩn quốc tế, bao gồm TAM (Total Addressable Market), SAM (Serviceable Addressable Market) và SOM (Serviceable Obtainable Market)

1.1 Thị trường tiềm năng tối đa (TAM):

TAM của EyeCU được xác định là toàn bộ hệ thống các cơ sở y tế lưu trú và điều dưỡng trên quy mô toàn quốc. Tính đến năm 2026, phân khúc này được ước lượng khoảng hơn 1.400 bệnh viện công lập và tư nhân (từ tuyến Trung ương, tuyến Tỉnh đến tuyến Huyện), mạng lưới các trung tâm y tế quận/huyện sở hữu giường bệnh nội trú, cùng hệ thống các trung tâm điều dưỡng và viện dưỡng lão đang tăng trưởng mạnh mẽ dưới áp lực của làn sóng già hóa dân số. Đây là giới hạn trần lý tưởng mà giải pháp có thể bao phủ khi đạt 100% thị phần.

$$\text{TAM} = \text{Số bệnh viện công lập} + \text{Số bệnh viện tư nhân} + \text{Số viện dưỡng lão/trung tâm điều dưỡng có lưu trú} \approx 1.400 \text{ cơ sở}$$

1.2 Thị trường mục tiêu có thể tiếp cận (SAM):

Trực quan hóa từ bộ lọc TAM, nhóm tập trung thu hẹp phạm vi vào phân khúc thị trường SAM giàu tiềm năng và có mức độ sẵn sàng cao nhất về mặt hạ tầng công nghệ lẫn ngân sách đầu tư. SAM của dự án được định vị cụ thể là khoảng 350 cơ sở y tế cao cấp, bao gồm: các bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, bệnh viện hạng 1 (tuyến trung ương và tuyến tỉnh), các bệnh viện quốc tế tư nhân, cùng mạng lưới viện dưỡng lão tư nhân có quy mô lớn. Đây là những đơn vị đang đối mặt gay gắt nhất với nỗi đau quá tải phòng cấp cứu, khủng hoảng điều dưỡng trực đêm và có năng lực tài chính chi trả cho các giải pháp chuyển đổi số toàn diện.

$$\text{SAM} = \text{TAM} \times 25\% = 1.400 \times 0,25 = 350 \text{ cơ sở}$$

1.3 Thị trường có thể chiếm lĩnh trong ngắn hạn (SOM):

Trong cột mốc 18 tháng đầu tiên kể từ khi ra mắt sản phẩm MVP ở Vòng 2, mục tiêu thực tế và khả thi tối thiểu của EyeCU là đánh chiếm thành công 10% dung lượng thị trường SAM, tương đương với 35 cơ sở y tế thuộc phân khúc cao cấp. Nhóm sẽ ưu tiên tiếp cận các bệnh viện tư nhân quốc tế và khoa lão khoa/cấp cứu của các bệnh viện lớn tại các đô thị trọng điểm như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Đây là bộ phóng chiến lược giúp hệ thống nhanh chóng chứng minh hiệu quả kinh tế lâm sàng, thu hồi vốn đầu tư công nghệ ban đầu (ROI) và tạo hiệu ứng lan tỏa sang các cơ sở y tế công lập ở giai đoạn tiếp theo.

$$\text{SOM} = \text{SAM} \times \text{Tỷ lệ thâm nhập mục tiêu} = 350 \times 10\% = 35 \text{ cơ sở}$$

2 Chiến lược tiếp cận thị trường bứt phá (Go-to-market Strategy)

Để giải quyết bài toán phức tạp về quy trình phê duyệt ngân sách trong lĩnh vực y tế, EyeCU thiết lập chiến lược thâm nhập thị trường (GTM) theo 3 giai đoạn tinh gọn, tối ưu hóa nguồn lực và phòng ngừa rủi ro kinh doanh:

- **Giai đoạn 1: Thâm nhập & Thực chứng lâm sàng (Tháng 08 – 10/2026):**

Triển khai chương trình chạy thử nghiệm (Pilot) miễn phí 3 tháng tại 1-2 cơ sở y tế đa khoa tuyến đầu. Để vượt qua rào cản thủ tục đấu thầu công phức tạp, dự án sẽ tiếp cận dưới hình

thức "*Đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học ứng dụng AI*". Giai đoạn này không đặt nặng doanh thu, mục tiêu tối thượng là thu thập các chỉ số hiệu quả vận hành thực tế (Case Study) về việc bảo vệ "thời gian vàng" cấp cứu, làm đòn bẩy thương mại (Commercial Leverage) vững chắc cho giai đoạn sau.

- **Giai đoạn 2: Định hướng Liên minh Chiến lược (Alliances Strategy):**

Thay vì tự xây dựng kênh phân phối B2B tốn kém, nhóm đề xuất tiếp cận Tập đoàn VNPT với mô hình Chia sẻ doanh thu. Cụ thể, EyeCU sẽ hoạt động như một tiện ích mở rộng cao cấp (Certified Add-on) tích hợp trực tiếp vào hệ sinh thái phần mềm VNPT HIS. Đây là mô hình cộng sinh đôi bên cùng có lợi: VNPT lập tức nâng cấp hàm lượng công nghệ cho gói HIS hiện tại để tăng sức cạnh tranh mà không chịu rủi ro R&D; ngược lại, EyeCU tận dụng được tệp khách hàng bệnh viện khổng lồ sẵn có của VNPT để bùng nổ quy mô SOM với Chi phí thu hút khách hàng (CAC) tiệm cận mức không.

- **Giai đoạn 3: Mở rộng Quy mô (Scale-up) (Từ tháng 11/2026 trở đi):**

Sau khi sở hữu Case Study thành công từ Giai đoạn 1, tiến hành chào hàng trực tiếp tới các chuỗi bệnh viện đa khoa tư nhân quy mô lớn. Đây là nhóm khách hàng có ngân sách công nghệ dồi dào, quy trình ra quyết định nhanh và áp lực cạnh tranh chất lượng dịch vụ nội trú cực kỳ khốc liệt. Song song, dự án định hướng đăng ký tham gia các chương trình ươm tạo cấp quốc gia để tiếp cận các luồng ngân sách công và hòa nhập vào chính sách y tế số quốc gia.

3 Mô hình doanh thu và Chiến lược định giá (Revenue Model)

EyeCU không đi theo mô hình bán bản quyền phần mềm một lần (on-premise) truyền thống vốn gây áp lực lớn lên chi phí đầu tư cố định (CAPEX) của bệnh viện. Thay vào đó, dự án tiên phong áp dụng mô hình doanh thu B2B SaaS (Software-as-a-Service) thu phí định kỳ dựa trên quy mô số đầu giường bệnh được quản lý thời gian thực. Mô hình này giúp chuyển dịch chi phí đầu tư công nghệ của các cơ sở y tế sang chi phí vận hành (OPEX) linh hoạt, tối ưu hóa dòng tiền và giảm thiểu tối đa rào cản tiếp cận giải pháp. Doanh thu của hệ thống được cơ cấu thông qua hai trục cốt lõi:

- **Phí triển khai và Cấu hình ban đầu:** Đây là khoản phí thu một lần duy nhất cho mỗi cơ sở y tế khi bắt đầu setup hệ thống. Khoản phí này bao gồm chi phí khảo sát thực địa, cấu hình và mapping hệ thống Core Server (FastAPI) tương thích với hạ tầng HIS/EMR sẵn có của bệnh viện thông qua chuẩn kết nối HL7/FHIR, thiết lập hệ thống camera biên và mảng micro, huấn luyện prompt chuyên sâu cho nhân viên y tế và bàn giao giao diện trạm chỉ huy Command Center.
- **Phí thuê bao phần mềm định kỳ (Subscription Fee):** Doanh thu chính, bền vững và liên tục của EyeCU đến từ việc thu phí bản quyền phần mềm theo tháng hoặc theo năm dựa trên số lượng giường bệnh tích hợp nhận thức không gian (Per-Bed Pricing). Mô hình này được phân tách làm hai phân hệ gói dịch vụ linh hoạt: Gói nội trú thông minh (tập trung tối ưu thị giác máy tính phát hiện ngã ban đêm và trích xuất y lệnh rảnh tay tại giường bệnh) và Gói cấp cứu thông minh (tập trung tối ưu thuật toán bề nhánh dữ liệu, tự động điều phối IoT và thông dịch chỉ số xét nghiệm ngoại trú). Đối với các bệnh viện triển khai quy mô lớn, hệ thống sẽ cung cấp các gói chiết khấu thương mại nhằm kích thích việc mở rộng độ phủ ra toàn bộ các khoa phòng.

Sự kết hợp giữa mô hình định giá SaaS linh hoạt này giúp bệnh viện tối ưu hóa hiệu suất sử dụng phòng cấp cứu lên thêm 30%, kéo giảm tỷ lệ lãng phí thời gian hành chính và mang lại thời gian hoàn vốn đầu tư công nghệ dự kiến chỉ trong vòng 6 đến 8 tháng từ khi triển khai, biến EyeCU thành một khoản đầu tư công nghệ có tính sinh lời cao đối với mọi nhà vận hành y tế.

4 Định lượng chỉ số hiệu quả đầu tư (ROI) và Tác động vận hành

Để chứng minh tính khả thi kinh tế và tạo niềm tin tuyệt đối trước Hội đồng chuyên môn, đội ngũ phát triển áp dụng phương pháp luận Kế thừa và chuyển dịch chỉ số từ các mô hình y tế quốc tế đã thành công (SafelyYou - Mỹ, Artisight - Singapore) làm điểm tựa định lượng. Dựa trên mô hình dữ liệu mô phỏng cho một cơ sở y tế tại Việt Nam với quy mô thử nghiệm 50 giường bệnh, EyeCU mang lại những đột phá mạnh mẽ về cả hiệu suất lâm sàng lẫn bài toán tối ưu hóa chi phí cho nhà vận hành:

- **Tối ưu hóa thời gian và giảm tải áp lực nhân sự:** Phân hệ Ambient Voice AI (Speech-to-Text) của EyeCU được thiết kế tương thích với cơ chế trích xuất dữ liệu rảnh tay của hệ thống Artisight – giải pháp đã được chứng minh giúp rút ngắn thời gian nhập liệu và thủ tục hành chính. Khi áp dụng thực tế vào quy mô 50 giường bệnh, hệ thống được kỳ vọng cắt giảm tới 65% thời gian hành chính lâm sàng, giúp mỗi điều dưỡng tiết kiệm trung bình 2,5 giờ công trong mỗi ca trực. Quy đổi quỹ thời gian này thành giá trị kinh tế, hệ thống giúp cơ sở y tế tiết kiệm một khoản chi phí nhân sự hành chính ước tính lên tới 120.000.000 VND/năm/khoa phòng. Quỹ thời gian dư ra này được tái đầu tư trực tiếp vào công tác túc trực và chăm sóc bên giường bệnh.
- **Bảo toàn "Thời gian vàng" cấp cứu và giảm thiểu rủi ro:** Phân hệ thị giác máy tính và tự động bề nhánh điều phối hạ tầng của EyeCU được phát triển dựa trên cảm hứng từ kiến trúc xử lý biên của SafelyYou – mô hình quốc tế đã chứng minh khả năng kéo giảm tới 80% số ca chuyển viện cấp cứu không cần thiết nhờ phát hiện sớm và đánh giá đúng tính chất cú ngã. Tại Việt Nam, quy trình điều phối tự động (tự động mở barrier xe, điều thang máy, kích hoạt thiết bị) giúp EyeCU rút ngắn 80% thời gian phản ứng khẩn cấp, kéo giảm thời gian chuẩn bị từ 5 – 7 phút hành chính bị động xuống dưới mức 60 giây. Việc bảo vệ trọn vẹn "thời gian vàng" này giúp giảm thiểu tỷ lệ tử vong và di chứng tàn phế cho bệnh nhân đột quỵ, tim mạch.
- **Thời gian hoàn vốn đầu tư tối ưu:** Tận dụng kiến trúc Hạ tầng siêu nhẹ, hệ thống tích hợp trực tiếp vào mạng lưới camera IP và micro sẵn có của cơ sở y tế. Chi phí vận hành máy chủ đám mây phục vụ xử lý thuật toán cho quy mô 50 giường bệnh ước tính chỉ đạt mức tối thiểu là 8.000.000 VND/tháng. Trong khi đó, bằng việc tối ưu hóa quy trình tiếp nhận và hỗ trợ xuất viện nhanh, EyeCU giúp bệnh viện nâng cao hiệu suất khai thác sử dụng phòng cấp cứu và giường bệnh nội trú lên thêm 30%. Sự gia tăng công suất này, kết hợp với dòng doanh thu mới từ việc thu hút khách hàng đến khám sức khỏe tổng quát nhờ tính năng Trợ lý ảo thông dịch chỉ số bằng LLM, giúp tối ưu hóa giá trị vòng đời khách hàng cho bệnh viện. Tính toán định lượng tài chính chỉ ra rằng, hệ thống mang lại thời gian hoàn vốn đầu tư công nghệ vô cùng lý tưởng, dự kiến hoàn thành trong vòng 6 đến 8 tháng.

VI PHỤ LỤC

1 THUẬT TOÁN ĐỊNH LƯỢNG CHỈ SỐ RỦI RO NHẬN THỨC

Để chứng minh tính an toàn lâm sàng và năng lực xử lý dữ liệu thời gian thực, máy chủ trung tâm của hệ điều hành EyeCU ứng dụng mô hình tối ưu toán học để liên tục tính toán **Chỉ số Rủi ro Nhận thức** (RI - Risk Index) cho từng giường bệnh nội trú:

$$RI = w_1 \cdot f_{\text{pose}}(\theta) + w_2 \cdot f_{\text{audio}}(dB) + w_3 \cdot f_{\text{keyword}}(\text{intent}) \quad (1)$$

1.1 Giải nghĩa chi tiết các biến số và hàm số thành phần

- **RI (Risk Index):** Chỉ số rủi ro nhận thức thời gian thực, có giá trị chuẩn hóa ngặt trong đoạn $[0, 1]$. Khi giá trị hệ thống tính toán vượt ngưỡng giới hạn nghiêm ngặt $RI > 0.75$, lệnh

báo động đổ lập tức được kích hoạt cường bức về máy hộ lý trực ban.

- $f_{\text{pose}}(\theta)$: Hàm đo lường sự thay đổi góc nghiêng và tọa độ trọng tâm khung xương cơ thể. Hàm số này nhận dữ liệu đầu vào từ mô-đun phát hiện người của API VNPT SmartVision 8.1, liên tục trích xuất và phân tích ma trận tọa độ của 33 điểm mốc (*landmarks*) trên cơ thể bệnh nhân theo thời gian thực để tính toán gia tốc rơi tự do và góc nghiêng cấu trúc động học của một cú ngã.
- $f_{\text{audio}}(\text{dB})$: Chỉ số cường độ âm thanh biên độ lớn vượt ngưỡng (đo bằng Decibel - *dB*) trích xuất từ mô-đun API VNPT SmartVoice 3.2 chạy ngầm tại phòng bệnh. Hàm này chịu trách nhiệm bắt các xung âm thanh đột biến có tần số cao phản ánh hiện tượng va đập, rơi vỡ vật lý hoặc tiếng động mạnh xuất hiện trong không gian.
- $f_{\text{keyword}}(\text{intent})$: Hàm kích hoạt biến số nhị phân nhận giá trị rời rạc (0 hoặc 1). Biến số chuyển sang giá trị 1 ngay khi bộ dịch VNPT SmartVoice 3.2 nhận diện và trích xuất chính xác các từ khóa *intent* kêu cứu khẩn cấp bằng Việt ngữ (ví dụ: "*Cứu tôi*", "*Bác sĩ ơi*", "*Đau quá*") từ luồng âm thanh hội thoại tự nhiên.

1.2 Cơ chế tối ưu trọng số và kiểm soát sai số lâm sàng

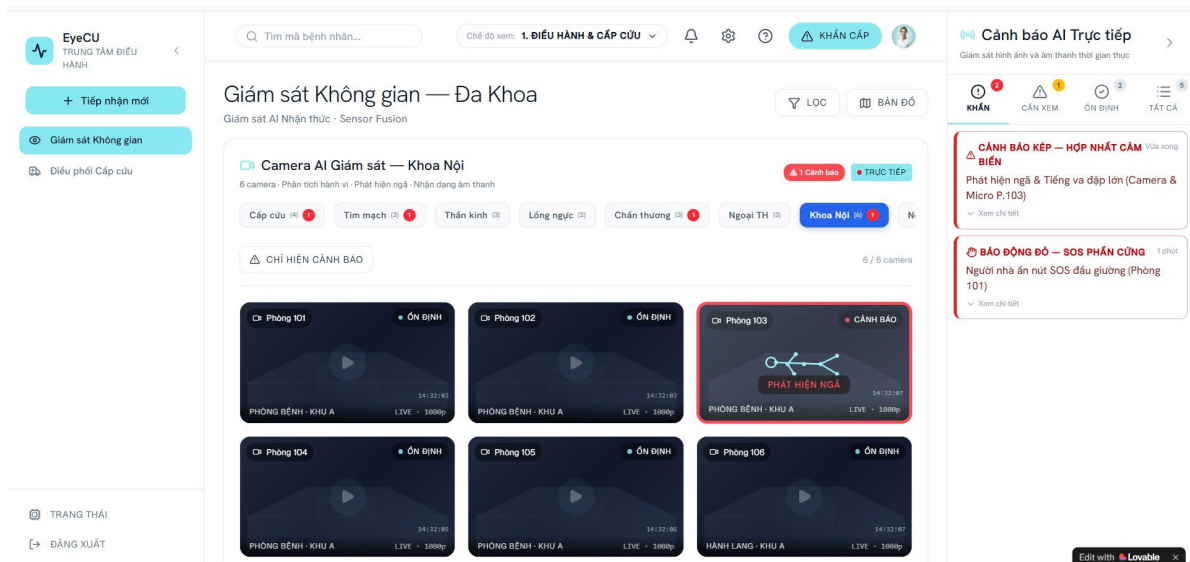
- **Ma trận trọng số** (w_1, w_2, w_3): Các trọng số này đại diện cho mức độ đóng góp và tầm quan trọng của từng phân hệ cảm biến (Thị giác máy tính và Thính giác máy tính) vào chỉ số rủi ro chung.
- **Giảm thiểu tỷ lệ báo động giả (*False Alarm Rate*)**: Trong môi trường y khoa thực tế, các biến số thô thường xuyên bị nhiễu bởi bối cảnh (như chấn gối che khuất khung xương hoặc tiếng ồn từ các thiết bị y tế xung quanh). Do đó, thay vì gán trọng số cố định, nhóm thiết lập cơ chế hiệu chuẩn động ma trận trọng số thông qua **ma trận hiệp phương sai** dựa trên tập dữ liệu thử nghiệm. Việc tối ưu hóa toán học này giúp hệ thống phân biệt chính xác giữa một cú ngã thực sự với các hành vi sinh hoạt bình thường của bệnh nhân (như cúi người tìm đồ vật dưới gầm giường), đảm bảo hệ thống đạt độ chính xác phát hiện ban đầu trên 99%.

2 Sản phẩm dự án

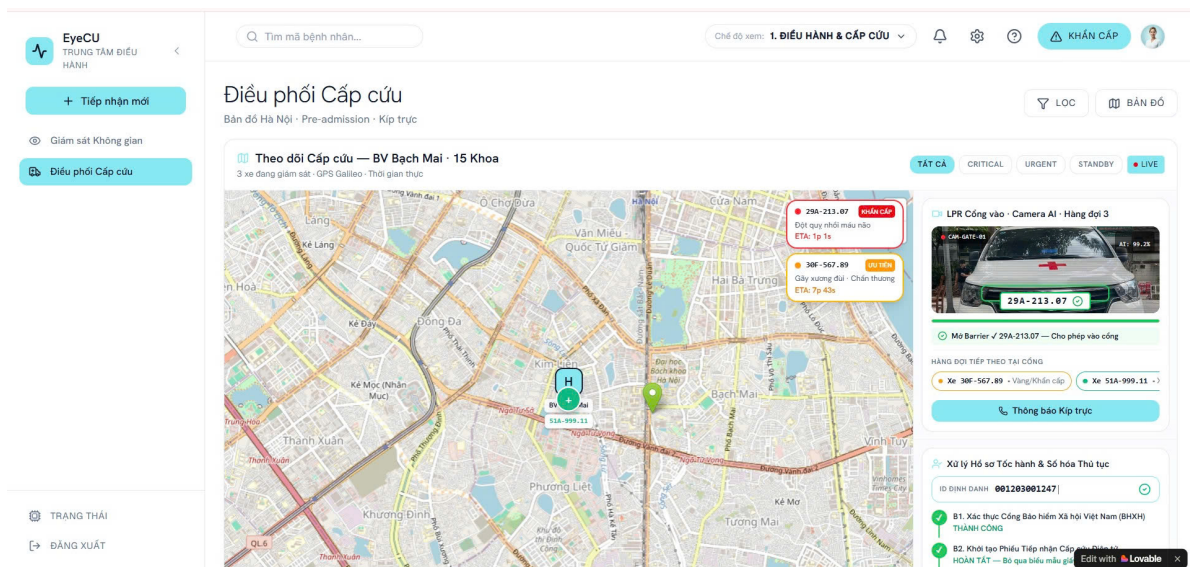
Đội ngũ dự án cung cấp các đường dẫn liên kết liên quan đến hệ điều hành EyeCU dưới đây:

Tài nguyên dự án	Đường dẫn truy cập
Web demo	Xem trực tuyến web demo
Slide thuyết trình	Xem trực tuyến bản Slide Đề xuất Dự án
Video Demo & Trình bày	Xem Video Thuyết trình sản phẩm

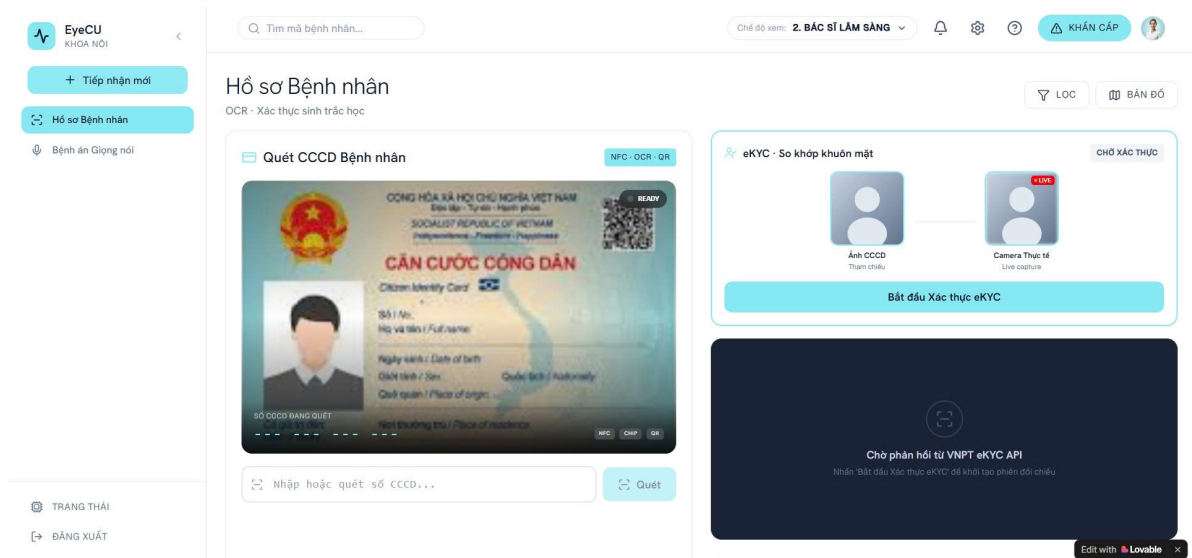
Bảng 4: Hệ thống liên kết tài nguyên trực tuyến của hệ điều hành EyeCU



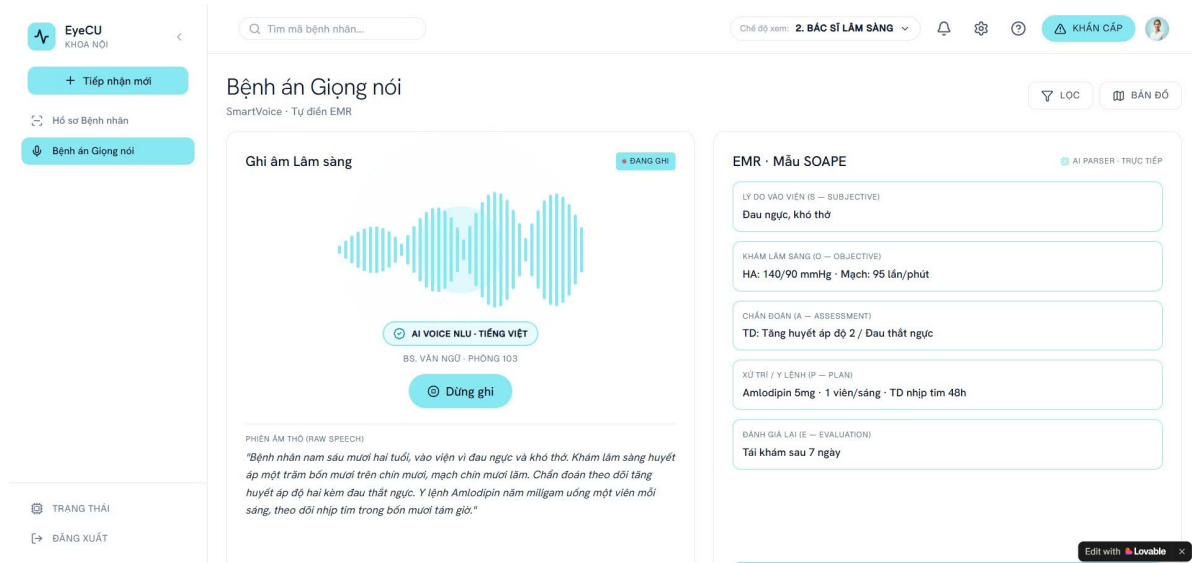
Hình 5: Giám sát Không gian



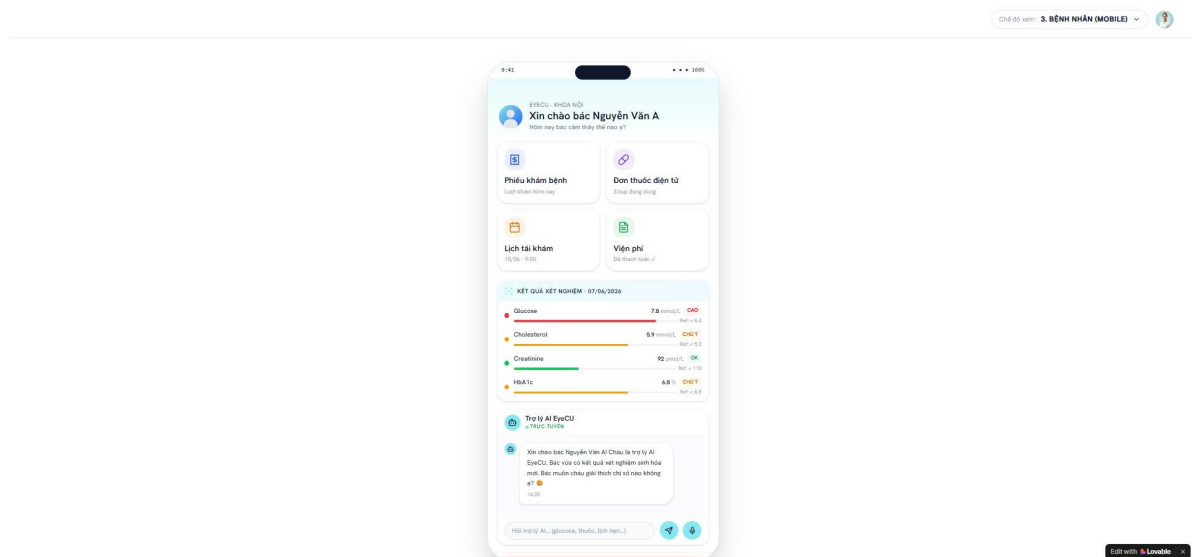
Hình 6: Điều phối cấp cứu



Hình 7: Hồ sơ bệnh nhân



Hình 8: Bệnh án giọng nói



Hình 9: Bệnh nhân (Mobile)

Tài liệu

- [1] Tổng cục Thống kê, *Báo cáo Điều tra dân số giữa kỳ*, 2025.
- [2] United Nations Population Fund (UNFPA) Vietnam, *Già hóa dân số*, 2025.
- [3] National Statistics Office of Vietnam, *Xu hướng già hóa dân số nhanh ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp*, 2025.
- [4] Hội Điều dưỡng Việt Nam & Cục Quản lý Khám chữa bệnh, *Khủng hoảng thiếu hụt điều dưỡng tại các cơ sở y tế công lập*, 2025.
- [5] Medical Park Clinical Network, *The Golden Hour in Neurology and Emergency Stroke Intervention*, 2024.
- [6] World Stroke Organization (WSO), *Time Is Brain: Quantitative Estimation of Brain Destruction in Stroke*, 2024.
- [7] National Investment Center (NIC), *SafelyYou Clinical Fall Reduction Evaluation Case Study*, 2021.
- [8] SafelyYou Research Lab, *Reduction of Emergency Room Visits and Floor Dwell Time via Edge AI*, 2022.
- [9] VietnamNet, *Ứng dụng trợ lý AI giải phóng giờ công hành chính cho y bác sĩ*, 2025.
- [10] Artisight Analytics, *The Guthrie Clinic Virtual Care and Ambient Voice Impact Report*, 2024.
- [11] The Guthrie Clinic Operations, *Reducing Nurse Turnover and Falls with Ambient AI Integration*, 2025.
- [12] VNPT Smart Cloud, *Biểu giá niêm yết dịch vụ hạ tầng điện toán đám mây Cloud Compute Gói SMC*, 2026.
- [13] oneSME VNPT, *Cổng thông tin cấu hình và biểu phí block tài nguyên SSD/Backup/Băng thông mở rộng*, 2026.